PRÜFUNGSTRAINING · SCHRIFTLICHES EXAMEN

Pflegeexamen: 300 Prüfungsfragen

Multiple-Choice-Fragen aus allen großen Fachbereichen der generalistischen Pflegeausbildung – mit Lösungsschlüssel und verständlichen Erklärungen.

Bestehen ist planbar.

Generalistik | Multiple Choice | Erklärungen | Lösungsschlüssel

300	15	A4
Fragen	Themenbereiche	druckfertig

INHALT

1. Generalistische Ausbildung & Recht
2. Pflegeprozess & Pflegeplanung
3. Prävention & Gesundheitsförderung
4. Mobilität & Bewegung
5. Notfall & Akutsituationen
6. Innere Medizin
7. Chirurgie
8. Pädiatrie
9. Gynäkologie & Geburtshilfe
10. … und 6 weitere Bereiche

⚠ Lernhilfe, mit KI-Unterstützung erstellt und fachlich geprüft. Maßgeblich sind Lehrinhalte, Leitlinien und Standards deiner Einrichtung.

Patrick Schenkelberger · Fachpfleger Anästhesie & Intensivmedizin, Praxisanleiter

plan-nrw.de

So nutzt du das Heft

Erst alle Fragen eines Bereichs beantworten, dann im Lösungsteil kontrollieren. Falsche Antworten markieren und nach ein paar Tagen wiederholen.

SCHWIERIGKEIT

● leicht · ●● mittel · ●●● schwer

EHRLICH TESTEN

Lösungen und Erklärungen stehen gesammelt am Ende – kein Spoiler beim Lernen.

THEMENBEREICHE

01 Generalistische Ausbildung & Recht · 20 Fragen
02 Pflegeprozess & Pflegeplanung · 20 Fragen
03 Prävention & Gesundheitsförderung · 20 Fragen
04 Mobilität & Bewegung · 20 Fragen
05 Notfall & Akutsituationen · 20 Fragen
06 Innere Medizin · 20 Fragen
07 Chirurgie · 20 Fragen
08 Pädiatrie · 20 Fragen
09 Gynäkologie & Geburtshilfe · 20 Fragen
10 Psychiatrie · 20 Fragen
11 Psychologie & Kommunikation · 20 Fragen
12 Altenpflege & Geriatrie · 20 Fragen
13 Palliativpflege · 20 Fragen
14 Rehabilitation · 20 Fragen
15 Anatomie: Herz & Kreislauf · 20 Fragen

© PLAN Digital · Patrick Schenkelberger. Nur für den persönlichen Gebrauch. Weitergabe, Weiterverkauf und Veröffentlichung nicht gestattet.

1 Generalistische Ausbildung & Recht

20 Fragen

1 **Aus welchen 3 Teilen besteht die staatliche Abschlussprüfung GPA?** ●●

A Schriftlich und mündlich
B Schriftlich, mündlich, praktisch
C Praktisch und Portfolio
D Nur Portfolio

2 **Welche 6 Schritte hat der Pflegeprozess?** ●

A Anamnese, ärztliche Diagnose und anschließende Therapie
B Aufnehmen, Pflegen und schließlich Entlassen des Patienten
C Beobachten, Handeln und abschließend Dokumentieren
D Informationssammlung, Pflegediagnose, Ziele, Maßnahmen, Durchführung, Evaluation

3 **Was ist Evaluation im Pflegeprozess?** ●●

A Pflegediagnose stellen
B Durchführung der Maßnahmen
C Aufnahme des Patienten
D Überprüfung ob Pflegeziele

4 **Was sind Expertenstandards des DNQP?** ●●

A Wissenschaftlich fundierte Vorgaben für zentrale Pflegethemen (z. B. Dekubitus, Sturz, Schmerz)
B Reine unverbindliche Empfehlungen ohne jede fachliche Grundlage
C Verbindliche Gesetze, die vom Bundestag beschlossen werden
D Interne Regeln, die nur für eine einzelne Station gelten

5 **Wie viele Stunden umfasst die generalistische Pflegeausbildung insgesamt etwa?** ●●

A Rund 500 Stunden, aufgeteilt auf Theorie und Praxis
B Rund 4600 Stunden (etwa 2100 Theorie + 2500 Praxis)
C Rund 100 Stunden im Rahmen eines kurzen Grundkurses
D Deutlich über 20.000 Stunden über die gesamte Ausbildung

6 **Welche Versorgungsbereiche decken die Pflichteinsätze der generalistischen Ausbildung ab?** ●●

A Stationäre Akutpflege, stationäre Langzeitpflege und ambulante Pflege
B Ausschließlich die Versorgung von Patienten auf der Intensivstation
C Ausschließlich verwaltende und organisatorische Tätigkeiten der Einrichtung
D Ausschließlich die Assistenz bei Operationen im OP-Bereich

7 **Welchen Vorteil bietet der generalistische Abschluss im europäischen Kontext?** ●●

A Er gilt ausschließlich innerhalb des Bundeslandes NRW
B Er ist im europäischen Ausland gar nicht anerkannt
C Er ist EU-weit anerkannt und erleichtert das Arbeiten im europäischen Ausland
D Er muss in jedem Bundesland vollständig neu erworben werden

8 **Was ist der Pädiatrie-Pflichteinsatz in der GPA?** ●●

(A) Ein rein optionaler Einsatz ohne festgelegte Mindeststundenzahl

(B) Ein Pflichteinsatz im Umfang von insgesamt 300 Stunden

(C) Ein Wahlpflichteinsatz von 500 Stunden am Ende der Ausbildung

(D) Pflicht: 120h Kinder- und Jugendmedizin

9 **Was bedeutet SMART bei Pflegezielen?** ●●

(A) Spezifisch, Messbar, Attraktiv, Realistisch, Terminiert

(B) Standard, Medizinisch, Ärztlich, Realistisch, Täglich

(C) Sicher, Modern, Akut, Risikoarm, Terminiert

(D) Schnell, Messbar, Akzeptiert, Realistisch, Terminiert

10 **Was ist der Ausbildungsplan des Trägers der praktischen Ausbildung?** ●●

(A) Ein individueller Plan, der die praktischen Einsätze und Lernziele strukturiert

(B) Der Dienstplan der examinierten Pflegekräfte der Einrichtung

(C) Ein reiner Plan zur Verteilung der Urlaubstage im Team

(D) Die wöchentliche Speisekarte der Ausbildungseinrichtung

11 **Welche schulische Zugangsvoraussetzung gilt üblicherweise für die generalistische Pflegeausbildung?** ●●

(A) Ausschließlich das Abitur oder eine gleichwertige allgemeine Hochschulreife

(B) Ein mittlerer Schulabschluss oder ein Hauptschulabschluss mit abgeschlossener Ausbildung bzw. Pflegeassistenz

(C) Gar kein bestimmter Schulabschluss, da der Zugang zur Ausbildung völlig frei ist

(D) Ein bereits erfolgreich abgeschlossenes Studium in einem medizinischen Fachbereich

12 **Was sind „vorbehaltene Tätigkeiten“ nach dem Pflegeberufegesetz?** ●●●

(A) Tätigkeiten, die nur ausgebildeten Pflegefachpersonen vorbehalten sind (z. B. Erhebung und Steuerung des Pflegeprozesses)

(B) Bestimmte organisatorische Aufgaben im Bereich der Stationsverwaltung und Ablaufplanung

(C) Reine hauswirtschaftliche und Reinigungstätigkeiten im Umfeld der Pflegeeinrichtung

(D) Alltägliche Aufgaben, die grundsätzlich jede beliebige Person ohne Ausbildung übernehmen darf

13 **Was ist der Orientierungseinsatz zu Beginn der Ausbildung?** ●●

(A) Die abschließende praktische und schriftliche Prüfung am Ende der Ausbildung

(B) Ein reiner theoretischer Unterrichtsblock ganz zu Beginn der Ausbildung

(C) Der frei wählbare Vertiefungseinsatz im letzten Ausbildungsdrittel

(D) Der erste Praxiseinsatz beim Träger der praktischen Ausbildung zum Ankommen und Orientieren

14 **Was sind CE 01-11 in der GPA?** ●●

(A) Einzelne schriftliche und mündliche Prüfungen im Verlauf der Ausbildung

(B) Die verschiedenen praktischen Einsätze in Klinik und ambulanter Pflege

(C) Erworbene Zusatzzertifikate für einzelne Fachbereiche der Pflege

(D) Curriculare Einheiten = Lernbereiche der generalistischen Pflegeausbildung

15 **Was ist Salutogenese nach Antonovsky?** ●●●

(A) Beatmungsmethode

(B) Krankheitsentstehung

(C) Was hält Menschen gesund (Gesundheitsentstehung)

(D) Pflegemodell chronisch Kranke

16 **Was unterscheidet Nah- von Fernzielen in der Pflegeplanung?** ●●

(A) Die Nahziele sind für die Pflegeplanung ohne Bedeutung

(B) Zwischen Nah- und Fernzielen besteht kein Unterschied

(C) Nahziele sind kurzfristig erreichbar, Fernziele beschreiben ein längerfristiges Gesamtergebnis

(D) Die Fernziele werden grundsätzlich immer als Erstes erreicht

17 **Was versteht man in der Pflegeplanung unter „Ressourcen“?** ●●

(A) Ausschließlich die verfügbaren finanziellen Mittel des Patienten

(B) Ausschließlich das für die Pflege eingesetzte Personal

(C) Die bestehenden Erkrankungen und Beschwerden des Patienten

(D) Vorhandene Fähigkeiten und Stärken, auf denen die Pflege aufbauen kann

18 **Was gilt für die Ausbildungsvergütung in der generalistischen Pflegeausbildung?** ●

(A) Es wird während der gesamten Ausbildung keinerlei Vergütung gezahlt

(B) Die Auszubildenden müssen für die Ausbildung ein Schulgeld entrichten

(C) Auszubildende haben Anspruch auf eine angemessene Ausbildungsvergütung und zahlen kein Schulgeld

(D) Eine Vergütung wird ausschließlich im dritten Ausbildungsjahr gezahlt

19 **Was ist Kinästhetik-Grundprinzip?** ●●

(A) Nur von Physiotherapeuten anwendbar

(B) Natürliche Bewegungsmuster nutzen

(C) Schnelle Pflege ohne Hilfsmittel

(D) Vollständige Übernahme

20 **Wer ist in der generalistischen Ausbildung der „Träger der praktischen Ausbildung“?** ●●

(A) Die Berufsgenossenschaft als zuständiger Träger der gesetzlichen Unfallversicherung

(B) Das jeweilige Schulministerium des Bundeslandes als oberste zuständige Behörde

(C) Die Einrichtung, die den Ausbildungsvertrag schließt und die praktische Ausbildung verantwortet

(D) Die zuständige Krankenkasse als Kostenträger der monatlichen Ausbildungsvergütung

2 Pflegeprozess & Pflegeplanung

20 Fragen

21 **Was ist Pflegeüberleitung?** ●●

A Fortbildung
B Eine Pflegediagnose
C Übergabe innerhalb Station
D Strukturierte Weitergabe

22 **Was ist Schmerzmanagement nach Expertenstandard?** ●●

A Schmerzmittel nur auf Nachfrage
B Nur nach ärztlicher Anordnung handeln
C Systematische Einschätzung, Therapie und Evaluation des Schmerzes
D Schmerzen selbst beurteilen

23 **Was ist Dekubitus-Kategorie II?** ●●●

A Muskel/Knochen sichtbar
B Blasenbildung oder Erosion
C Vollhautverlust bis Subkutis
D Nicht-wegdrückbare Rötung

24 **Was sind die 4 Hauptbestandteile einer Pflegeplanung?** ●

A Pflegeproblem/Pflegediagnose, Pflegeziel
B Problem, Diagnose, Therapie, Entlassung
C Anamnese, Befund, Plan, Kontrolle
D Aufnahme, Behandlung, Pflege, Entlassung

25 **Was ist der Zweck der Evaluation im Pflegeprozess?** ●●

A Die Vorbereitung der Abrechnung mit dem Kostenträger
B Zu überprüfen, ob die Pflegeziele erreicht wurden, und die Planung ggf. anzupassen
C Die Organisation und Durchführung der Entlassung des Patienten
D Die Erstellung des wöchentlichen Dienstplans des Teams

26 **Was ist das Braden-Assessment?** ●●

A Risikoeinschätzungs-Skala
B Schmerztest
C Ernährungsbewertung
D Sturzrisikotest

27 **In welcher Reihenfolge wird PSA angelegt?** ●●

A Maske → Brille → Kittel → Handschuhe
B Alles gleichzeitig
C Kittel → Maske/Atemschutz → Schutzbrille → Handschuhe
D Handschuhe → Kittel → Maske → Brille

28 **Was ist das Orem-Pflegemodell?** ●●●

A AEDL-Modell
B Maslow-Modell
C Selbstpflegedefizit-Modell
D Salutogenese

29 **Was ist bei der Isolierung eines MRSA-Patienten zu beachten?** ●●●

(A) Der Patient darf grundsätzlich gar nicht besucht werden

(B) Einzelzimmer, Schutzkittel, Handschuhe und FFP2 bei engem Kontakt

(C) Es genügt das alleinige Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes

(D) Es genügt das alleinige Tragen von Einmalhandschuhen

30 **Welche Wäsche kommt in den roten Sack?** ●

(A) Gebrauchte Abdecktücher aus dem Operationssaal

(B) Ganz normale, nur leicht verschmutzte Bettwäsche

(C) Grundsätzlich die gesamte Wäsche aller Patienten

(D) Infektionswäsche – direkt verschlossen im Zimmer entsorgen

31 **Aus wie vielen Schritten besteht der Pflegeprozess im gängigen Modell?** ●●

(A) Aus sechs Schritten (von der Informationssammlung bis zur Evaluation)

(B) Aus genau zwei aufeinanderfolgenden Schritten

(C) Aus insgesamt zwölf einzelnen kleinen Schritten

(D) Aus einem einzigen zusammenhängenden Schritt

32 **Was ist die NRS und wie wird sie eingesetzt?** ●

(A) Nationales Sturzregister

(B) Reanimationsschema

(C) Numerische Rating-Skala

(D) Nutritional Risk Screening

33 **Was ist die Visuelle Analogskala (VAS) in der Schmerzerfassung?** ●●

(A) Ein spezielles Blutdruckmessgerät zur Erfassung schmerzbedingter Druckspitzen im Kreislauf

(B) Ein bestimmter Laborwert, der die Stärke eines entzündungsbedingten Schmerzes anzeigt

(C) Eine Skala, auf der der Patient seine Schmerzstärke auf einer Linie zwischen zwei Endpunkten markiert

(D) Ein bildgebendes Verfahren zur genauen Darstellung schmerzender Körperregionen

34 **Was sind potenzielle Pflegeprobleme?** ●●

(A) Medikamentennebenwirkungen

(B) Ärztliche Diagnosen

(C) Risiken/Gefährdungen, die noch nicht eingetreten sind

(D) Bereits eingetretene Probleme

35 **Wann sollten Einmalhandschuhe NICHT getragen werden?** ●

(A) Bei Wundversorgung

(B) Beim normalen Patientenkontakt

(C) Bei Katheteranlage

(D) Bei Blutentnahme

36 **Was ist ein korrektes SMART-Pflegeziel?** ●●

(A) Mobilität verbessern

(B) Patient geht am 3. Tag mit Hilfe 10m

(C) Schmerzen reduzieren

(D) Patient soll sich besser fühlen

37 **Was regelt §23 IfSG für Krankenhäuser?** ●●●

A Ausschließlich die Meldung an das zuständige Gesundheitsamt

B Die Regeln zur Abrechnung erbrachter Krankenhausleistungen

C Surveillance-Pflicht für nosokomiale Infektionen und Antibiotikaresistenzen

D Vorgaben zur personellen Mindestbesetzung der Stationen

38 **Wann müssen Hände gewaschen (nicht desinfiziert) werden?** ●●

A Nach jedem Patientenkontakt

B Immer vor der Desinfektion

C Nur bei sichtbarer Verschmutzung oder Sporenbildnern (z. B. C. difficile)

D Niemals – Desinfektion reicht immer

39 **Was kennzeichnet einen Dekubitus der Kategorie/Grad I?** ●●

A Eine nicht wegdrückbare Rötung bei intakter Haut

B Einen tiefen Krater mit freiliegendem Knochen

C Eine offene Blase mit Hautverlust

D Abgestorbenes, schwarzes Gewebe

40 **In welche drei Dimensionen wird Pflegequalität nach Donabedian eingeteilt?** ●●●

A Preis-, Zeit- und Personalqualität

B Klein-, Mittel- und Großqualität

C Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität

D Anfangs-, Mittel- und Endqualität

3 Prävention & Gesundheitsförderung

20 Fragen

41 **Welches Gesetz regelt die Meldepflicht bei bestimmten Infektionskrankheiten?** ●●

A Das Pflegeberufegesetz
B Das Betäubungsmittelgesetz
C Das Arbeitszeitgesetz
D Das Infektionsschutzgesetz (IfSG)

42 **Was bedeutet Empowerment in der Gesundheitsförderung?** ●

A Die wohlmeinende Bevormundung und Entscheidungsübernahme für den Patienten
B Die reine Weitergabe von Informationen ohne aktive Beteiligung des Patienten
C Befähigung zu mehr Selbstbestimmung und Kontrolle über die eigene Gesundheit
D Die gezielte Gabe von Medikamenten zur Verbesserung der Gesundheit

43 **Was unterscheidet Verhaltens- von Verhältnisprävention?** ●●

A Beide Formen zielen ausschließlich auf die Gabe von Medikamenten
B Die Verhältnisprävention ist grundsätzlich immer freiwillig
C Verhaltensprävention setzt am Individuum an, Verhältnisprävention an den Lebensbedingungen
D Beide Begriffe bezeichnen im Grunde genau dasselbe

44 **Was beschreibt der Begriff „Herdenimmunität“?** ●●

A Immunität, die nur bei Tieren vorkommt
B Lebenslange Immunität nach jeder Infektion
C Schutz Ungeimpfter durch eine hohe Impfquote in der Bevölkerung
D Immunität allein durch gesunde Ernährung

45 **Was ist das Ziel der Tertiärprävention?** ●●

A Krankheiten schon vor ihrer Entstehung vollständig verhindern
B Folgeschäden und Rückfälle einer bestehenden Erkrankung begrenzen (z. B. Reha)
C Bestehende Krankheiten in einem frühen Stadium erkennen
D Gesunde Menschen vorbeugend gegen Erreger impfen

46 **Wie hebt man beim Anheben von Lasten rückenschonend?** ●

A Mit rundem Rücken und gestreckten Beinen
B Ruckartig und möglichst schnell
C Aus den Beinen heben, Rücken gerade, Last nah am Körper
D Grundsätzlich allein und ohne Hilfsmittel

47 **Was unterscheidet Beratung von Anleitung in der Pflege?** ●●

A Die Beratung ist praktisch, die Anleitung dagegen theoretisch

B Beide Begriffe bezeichnen im Grunde genau dasselbe

C Eine Anleitung ist ausschließlich für Angehörige vorgesehen

D Beratung unterstützt Entscheidungsfindung, Anleitung vermittelt konkrete Handlung

48 **Womit prüft man, ob eine Hautrötung ein Dekubitus Kategorie 1 sein könnte?** ●●

A Mit dem Thermometer

B Mit dem Blutdruckmessgerät

C Mit einer Blutentnahme

D Mit dem Fingertest (Wegdrückbarkeit prüfen)

49 **Welche Maßnahme ist am wirksamsten gegen nosokomiale Infektionen?** ●

A Hygienische Händedesinfektion

B Antibiotika-Prophylaxe bei allen Patienten

C Tägliches Wischen der Fußböden

D Mundschutz für Besucher

50 **Wie werden gebrauchte Kanülen korrekt entsorgt?** ●

A Mit wieder aufgesteckter Schutzkappe in den Hausmüll

B In der Kitteltasche zwischensammeln

C Im Ausguss entsorgen

D Ohne Recapping direkt in einen durchstichsicheren Abwurfbehälter

51 **Welche Maßnahme ist bei einem Patienten mit MRSA typisch?** ●●

A Isolierung/Barrierepflege mit Schutzkittel und Handschuhen

B Keine besonderen Maßnahmen nötig

C Den Kontakt zu allen anderen Patienten fördern

D Antibiotika für die gesamte Station

52 **Wer gibt in Deutschland die offiziellen Impfempfehlungen heraus?** ●

A WHO

B STIKO am RKI

C Hausärzteverband

D Pflegekammer

53 **Was ist die erste Maßnahme nach einer Nadelstichverletzung?** ●●

A Blutung fördern, Wunde spülen/desinfizieren und melden

B Die Wunde sofort fest abdrücken und verschließen

C Sofort selbstständig Antibiotika einnehmen

D Die Verletzung ignorieren, wenn sie klein ist

54 **Wodurch beugt man Kontrakturen am wirksamsten vor?** ●●

A Vollständige Ruhigstellung der Gelenke

B Regelmäßige Bewegung und physiologische Lagerung der Gelenke

C Wärmflaschen auf die Gelenke legen

D Kalte Wickel anlegen

55 **Welche Maßnahme zählt zur physikalischen Thromboseprophylaxe?**

A Die strikte Einhaltung durchgehender und dauerhafter Bettruhe

B Frühmobilisation und medizinische Thromboseprophylaxestrümpfe

C Eine möglichst tiefe Lagerung beider Beine des Patienten

D Das Trinken großer Mengen von koffeinhaltigem Kaffee

56 **Was ist das Ziel der motivierenden Gesprächsführung (Motivational Interviewing)?**

A Den Patienten mit Nachdruck zu einer Entscheidung zu überreden

B Die eigene Veränderungsmotivation des Patienten stärken

C Dem Patienten klare Anweisungen und Vorgaben zu erteilen

D Eine ärztliche Diagnose für den Patienten zu stellen

57 **Was bedeutet Standard- bzw. Basishygiene?**

A Nur bei bekannten Infektionen anzuwenden

B Grundlegende Hygienemaßnahmen bei jedem Patienten unabhängig vom Infektionsstatus

C Nur auf Intensivstationen nötig

D Ausschließlich Händewaschen mit Seife

58 **Welche Maßnahme senkt das Aspirationsrisiko bei der Nahrungsaufnahme?**

A Den Patienten im Liegen füttern

B Aufrechte Sitzposition und angepasste Kostkonsistenz

C Große Bissen schnell anreichen

D Während des Schluckens ablenken

59 **Was ist ein Ziel des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)?**

A Krankenstände durch Druck senken

B Gesundheitsfördernde Arbeitsbedingungen schaffen und Beschäftigte gesund halten

C Gesetzliche Vorgaben nur minimal erfüllen

D Ausschließlich Kosten einsparen

60 **Welche Maßnahme dient der Pneumonieprophylaxe?**

A Flache Rückenlage ohne Bewegung

B Reichlich hustendämpfende Mittel

C Möglichst trockene Raumluft

D Atemübungen, Mobilisation und ggf. atemstimulierende Einreibung

4 Mobilität & Bewegung

20 Fragen

61 **Was gilt für freiheitsentziehende Maßnahmen (z. B. Fixierung) zur Sturzprophylaxe?** ●●●

A Sie gelten als Mittel der ersten Wahl bei jeder Sturzgefahr

B Sie dürfen jederzeit und ohne besonderen Grund angeordnet werden

C Sie sind grundsätzlich völlig frei von Risiken für den Betroffenen

D Sie sind letztes Mittel und bedürfen i. d. R. einer Einwilligung bzw. richterlichen Genehmigung

62 **Was beschreibt die Virchow-Trias?** ●●●

A Drei verschiedene Bereiche des Blutzuckerspiegels

B Die drei Schweregrade eines entstehenden Dekubitus

C Gefäßwandschaden, verlangsamter Blutfluss und erhöhte Gerinnungsneigung

D Drei aufeinanderfolgende Stufen des Bewusstseins

63 **Wann ist eine Wechseldruckmatratze sinnvoll?** ●●●

A Bei stark dekubitusgefährdeten, kaum mobilisierbaren Patienten

B Bei voll mobilen und gesunden, aktiven Personen

C Ausschließlich beim Auftreten von erhöhtem Fieber

D Vorrangig als Maßnahme zur Vorbeugung von Stürzen

64 **Wie beugt man einem Spitzfuß bei bettlägerigen Patienten vor?** ●●

A Durch Lagerung in 90-Grad-Stellung und regelmäßige Bewegung des Sprunggelenks

B Durch dauerhafte Streckung des Fußes

C Durch Hochlagern nur der Zehen

D Durch feste Bandage in Spitzfußstellung

65 **Wann ist ein Patientenlifter indiziert?** ●●

A Bei voll mobilen Patienten, die sich selbstständig bewegen können

B Grundsätzlich nie, da ein Transfer immer manuell erfolgen sollte

C Ausschließlich während der Nacht zur Entlastung des Personals

D Bei schwer immobilen Patienten, die nicht sicher manuell transferiert werden können

66 **Worin unterscheiden sich aktive und passive Bewegungsübungen?** ●

A Aktiv bewegt der Patient selbst, passiv wird er von der Pflegekraft bewegt

B Es gibt keinen Unterschied

C Passiv bedeutet gar keine Bewegung

D Aktiv geht nur mit einer Maschine

67 **Woran erkennt man einen Dekubitus Grad 1?** ●●

A An einer offenen, nässenden Wunde

B An schwarzem, nekrotischem Wundgrund

C An einem tiefen Krater bis zum Knochen

D An einer umschriebenen, nicht wegdrückbaren Rötung intakter Haut

68 **Was ist das wichtigste Prinzip der Kontrakturenprophylaxe?**

A Strikte Bettruhe
B Hochlagerung aller Gelenke
C Fixierung der Gelenke
D Regelmäßige Bewegung und physiologische Lagerung

69 **Wodurch unterscheidet sich ein Rollator von einem Gehbock?**

A Der Rollator hat Räder für flüssiges Gehen, der Gehbock wird angehoben und versetzt
B Beide Gehhilfen sind vollständig identisch und gleich zu bedienen
C Der Gehbock verfügt zusätzlich über einen elektrischen Antrieb
D Der Rollator ist ausschließlich für Kinder gedacht und gebaut

70 **Für welche Patientengruppe ist das Bobath-Konzept vor allem gedacht?**

A Frisch operierte Patienten mit einer Bauchwunde
B Ausschließlich Neugeborene und junge Säuglinge
C Menschen mit zentralen neurologischen Störungen, z. B. nach Schlaganfall
D Patienten mit einer harmlosen fieberhaften Erkältung

71 **Was umfasst die ATL/AEDL 'Sich bewegen'?**

A Positionswechsel, Transfer, Gehen und Bewegungsförderung
B Nur das selbstständige Gehen
C Nur die Nahrungsaufnahme
D Nur die Körperpflege

72 **Was ist das Ziel der Mikrolagerung (Mikrobewegung)?**

A Den Patienten jeweils vollständig auf die andere Seite umzudrehen
B Vor allem die Bettwäsche und die Matratze zu schonen
C Jede Form von Bewegung möglichst vollständig zu vermeiden
D Durch kleine Positionsveränderungen die Druckpunkte regelmäßig leicht zu verändern

73 **Welchen Nutzen hat kinästhetisches Arbeiten für die Pflegekraft?**

A Es ist reine Zeitverschwendung
B Es schont durch ressourcenorientierte Bewegung den eigenen Rücken
C Man muss deutlich mehr heben
D Es ersetzt die Dokumentation

74 **Was kennzeichnet einen individuellen Bewegungsförderungsplan?**

A Ein starres Schema für alle Patienten
B Ausschließlich ärztliche Anordnung ohne Pflege
C Den Verzicht auf Dokumentation
D An Ressourcen, Risiko und Zielen des Patienten ausgerichtete Maßnahmen

75 **Was kennzeichnet aktivierende Körperpflege?**

- A Pflegekraft übernimmt vollständig
- B Pflege nur durch Angehörige
- C Ressourcen des Patienten werden einbezogen
- D Verzicht auf Körperpflege

76 **Was bedeutet ein niedriger Punktwert in der Braden-Skala?**

- A Kein Dekubitusrisiko
- B Ein höheres Dekubitusrisiko
- C Guter Ernährungszustand
- D Ein niedriges Sturzrisiko

77 **Welche Sicherheitsmaßnahme gehört zu jedem Rollstuhl-Transfer?**

- A Die Feststellbremsen bewusst offen und gelöst lassen
- B Die Fußstützen des Rollstuhls unten und ausgeklappt lassen
- C Den Transfer ohne vorherige Ansage an den Patienten beginnen
- D Bremsen feststellen und auf festes Schuhwerk achten

78 **Bei welcher Erkrankung sind Kompressions- bzw. Thrombosestrümpfe mit Vorsicht anzuwenden oder kontraindiziert?**

- A Bei einer leichten Erkältung mit Schnupfen und Husten
- B Fortgeschrittene periphere arterielle Verschlusskrankheit (pAVK)
- C Bei völlig gesunden Beinen ohne jede Gefäßerkrankung
- D Bei anhaltenden Kopfschmerzen und Migräne des Patienten

79 **Warum ist Frühmobilisation nach Operationen wichtig?**

- A Sie erhöht das Risiko für Komplikationen nach der Operation
- B Sie senkt Thrombose-, Pneumonie- und Dekubitusrisiko und fördert die Genesung
- C Sie dient rein kosmetischen und ästhetischen Zwecken
- D Sie ist nach einer Operation grundsätzlich kontraindiziert

80 **Welche Folge ist typisch für längere Immobilität?**

- A Muskelabbau, Osteoporose und Obstipation
- B Zunahme der Muskelkraft
- C Bessere Gelenkbeweglichkeit
- D Sinkendes Thromboserisiko

5 Notfall & Akutsituationen

20 Fragen

81 **Wie stillt man eine starke äußere Blutung als Erstmaßnahme?** ●●

(A) Direkten Druck auf die Wunde ausüben, Druckverband anlegen, Körperteil hochhalten

(B) Zunächst abwarten und beobachten, ob die Blutung von selbst zum Stillstand kommt

(C) Die Wunde ausgiebig mit Wasser auswaschen und danach offen liegen lassen

(D) Ausschließlich die Wundränder desinfizieren und keinen Druck ausüben

82 **Was wird im ABCDE-Schema unter 'B' beurteilt?** ●

(A) Breathing – die Atmung (Atemfrequenz, SpO2, Auskultation)

(B) Der Blutzuckerspiegel und der allgemeine Stoffwechselzustand des Patienten

(C) Der arterielle Blutdruck und die aktuelle Herzfrequenz

(D) Der Bewusstseinszustand und die Reaktion der Pupillen auf Licht

83 **Wofür steht das FAST-Schema beim Schlaganfallverdacht?** ●●

(A) Fieber, Atemnot, Schmerz, Tremor

(B) Face, Arms, Speech, Time (Gesicht, Arme, Sprache, Zeit)

(C) Fast, Atem, Stabil, Transport

(D) Flüssigkeit, Antibiotika, Sauerstoff, Transport

84 **Wann wird mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung begonnen?** ●

(A) Erst wenn der Notarzt eintrifft

(B) Nur bei sichtbarem Herzstillstand im EKG

(C) Wenn die Person nicht reagiert und nicht normal atmet

(D) Erst nach 5 Minuten Wartezeit

85 **Was tut man bei einer bewusstlosen Person, die normal atmet?** ●●

(A) Atemwege freimachen, in stabile Seitenlage bringen, Notruf, Atmung überwachen

(B) Sofort und ohne weitere Prüfung mit der Herzdruckmassage beginnen

(C) Die Person aufsetzen und ihr etwas Wasser zu trinken geben

(D) Sie unbeobachtet und ohne weitere Maßnahmen allein lassen

86 **Nach welchem Prinzip wird das ABCDE-Schema abgearbeitet?** ●●

(A) Nach der persönlichen Sympathie und dem ersten Eindruck des Behandlers

(B) In zufälliger Reihenfolge, je nach gerade verfügbarem Material und Personal

(C) Grundsätzlich mit C beginnen und in jedem Fall zuerst den Kreislauf sichern

(D) 'Treat first what kills first' – feste Reihenfolge A vor B vor C und jeweils sofort behandeln

87 **Wofür steht das 'C' im ABCDE-Schema?**

- A Consciousness
- B Circulation
- C Control
- D Capillary

88 **Wofür steht das 'E' im ABCDE-Schema?**

- A Erhebung des Elektrolythaushalts und Beurteilung des Ernährungszustands
- B Elektrokardiogramm zur fortlaufenden Kontrolle des Herzrhythmus schreiben
- C Exposure/Environment – Entkleiden, Untersuchen, Wärmeerhalt
- D Erhebung der Eigen- und Fremdanamnese gemeinsam mit den Angehörigen

89 **Die MTS-Stufe GRÜN bedeutet ...**

- A 10 min
- B sofort
- C nicht dringend, 120 min
- D normal, 90 min

90 **Was wird im ABCDE-Schema ZUERST beurteilt?**

- A Exposure
- B Breathing
- C Airway
- D Disability

91 **Welche Schockform entsteht durch massiven Flüssigkeits- oder Blutverlust?**

- A Kardiogener Schock
- B Septischer Schock
- C Hypovolämischer Schock
- D Anaphylaktischer Schock

92 **Welcher Herzrhythmus ist bei der Reanimation defibrillierbar (schockbar)?**

- A Die Asystolie, also der vollständige Stillstand des Herzens
- B Kammerflimmern (VF) und pulslose ventrikuläre Tachykardie (pVT)
- C Die pulslose elektrische Aktivität ohne fühlbaren Puls
- D Der geordnete und regelmäßige normale Sinusrhythmus

93 **Was ist beim Einsatz eines AED (automatisierter externer Defibrillator) richtig?**

- A Einschalten und den Sprachanweisungen folgen; während der Analyse den Patienten nicht berühren
- B Ihn bei Ersthelfern und Laien grundsätzlich niemals einsetzen
- C Sofort und ohne vorherige Rhythmusanalyse einen Schock abgeben
- D Ihn ausschließlich bei Kindern und Säuglingen verwenden

94 **Worauf ist bei der Thoraxkompression zu achten?** ●●

A Eine möglichst weiche und nachgebende Unterlage unter dem Brustkorb

B Nur eine flache, oberflächliche Drucktiefe ohne vollständige Kompression

C Harte Unterlage, vollständige Entlastung nach jeder Kompression, Unterbrechungen minimieren

D Ein bewusst langsames und gleichmäßiges Drücken mit langen Pausen

95 **Welche Kompressionsfrequenz empfiehlt der ERC 2025 bei der Reanimation?** ●●

A 100–120/min

B 60–80/min

C 80–100/min

D 140–160/min

96 **Was ist die richtige Erstmaßnahme bei einer kleinflächigen Verbrennung?** ●●

A Die verbrannte Stelle sofort mit Eis oder einem Kühlakku direkt auf der Haut kühlen

B Butter, Speiseöl oder Mehl großzügig auf die verbrannte Hautstelle auftragen

C Mit lauwarmem Wasser kühlen, keine Hausmittel, Wunde locker keimarm bedecken

D Entstehende Brandblasen umgehend öffnen und die abgelöste Haut vorsichtig entfernen

97 **Wie beginnt die Reanimation beim Kind durch geschultes Personal (ERC 2025)?** ●●●

A Sofort mit 30 Herzdruckmassagen beginnen, noch vor jeder Beatmung

B Mit 5 initialen Beatmungen, dann Kompressionen zu Beatmungen im Verhältnis 15:2

C Ausschließlich beatmen und dabei ganz auf Kompressionen verzichten

D Im Verhältnis 30:2 vorgehen, jedoch vollständig ohne Beatmungen

98 **Nach welchem Prinzip wird im MTS die Dringlichkeit festgelegt?** ●●

A höchste zutreffende Stufe anhand von Indikatoren

B nach Alter des Patienten

C Reihenfolge des Eintreffens

D niedrigste zutreffende Stufe

99 **Wie lange sollte die Atem-/Kreislaufkontrolle bei der Reanimationsprüfung maximal dauern?** ●●

A Bis zu 1 Minute

B 30 Sekunden

C So lange wie nötig

D Maximal 10 Sekunden

100 **Welche Nummer ist der europaweite Notruf?** ●

A 110

B 116117

C 19222

D 112

6 Innere Medizin

20 Fragen

101 **Welche BGA-Konstellation spricht für eine metabolische Azidose (z. B. diabetische Ketoazidose)?** ●●●

(A) pH niedrig, HCO3 und Base Excess erniedrigt
(B) pH hoch, HCO3 erhöht
(C) pH hoch, pCO2 niedrig
(D) alle Werte erhöht

102 **Welches Symptom weist auf ein Lungenödem hin?** ●●●

(A) Eine trockene, unauffällige Haut ganz ohne begleitende Beschwerden
(B) Anhaltende, krampfartige Schmerzen im Bereich des Bauchraums
(C) Eine sichtbare Schwellung im Bereich der großen Gelenke
(D) Schwere Atemnot mit brodelnden Rasselgeräuschen, ggf. schaumiger Auswurf

103 **Welcher Normbereich gilt für Bikarbonat (HCO3-) im Blut?** ●●●

(A) 22–26 mmol/l
(B) 2–6 mmol/l
(C) 40–50 mmol/l
(D) 60–70 mmol/l

104 **Welche Folgeerkrankung droht bei langjähriger, unbehandelter arterieller Hypertonie?** ●●

(A) Bessere Nierenfunktion
(B) Gewichtsabnahme
(C) Sehverbesserung
(D) Schlaganfall, Herzinfarkt und Nierenschäden

105 **Was ist das wichtigste Pflegemonitoring bei Herzinsuffizienz?** ●●

(A) Tägliche Gewichtskontrolle
(B) Pupillenkontrolle
(C) Blutzucker
(D) Temperatur

106 **Ab welchen pH-Werten wird es akut lebensbedrohlich?** ●●●

(A) pH unter 7,0 oder über 7,8
(B) Bei den Normalwerten von pH 7,35 und pH 7,45
(C) Bereits bei einem leicht abweichenden pH von 7,30
(D) Bereits bei einem leicht abweichenden pH von 7,50

107 **Was unterscheidet Asthma bronchiale typischerweise von der COPD?** ●●

(A) Es gibt keinen Unterschied
(B) Asthma ist immer irreversibel
(C) Asthma ist meist anfallsartig und weitgehend reversibel
(D) Asthma betrifft nur ältere Raucher

108 **Welcher pH-Bereich des arteriellen Blutes gilt als normal?** ●●

(A) 6,8–7,0
(B) 7,35–7,45
(C) 7,60–7,80
(D) 8,0–8,4

109 **Was ist Dysphagie nach Schlaganfall und welche Gefahr besteht?** ●●

A Hörstörung
B Sehstörung
C Schluckstörung
D Gehstörung

110 **Was ist bei Abnahme und Verarbeitung einer BGA-Probe wichtig?** ●●●

A Möglichst viele Luftblasen in der Spritze belassen
B Die Probe über Stunden bei Zimmerwärme lagern
C Die Probe ganz ohne gerinnungshemmenden Zusatz abnehmen
D Luftblasen entfernen und die Probe rasch analysieren (heparinisierte Spritze)

111 **Worin unterscheiden sich Typ-1- und Typ-2-Diabetes grundsätzlich?** ●●

A Typ 1: absoluter Insulinmangel (Autoimmun); Typ 2: Insulinresistenz mit relativem Mangel
B Beide Diabetesformen sind identisch und unterscheiden sich nicht
C Der Typ 1 betrifft ausschließlich ältere Menschen
D Der Typ 2 erfordert grundsätzlich sofort eine Insulingabe

112 **Wie verändert sich die BGA bei einer respiratorischen Azidose (z. B. schwere COPD, Hypoventilation)?** ●●●

A pH hoch, pCO2 niedrig
B pH niedrig, HCO3 stark erniedrigt
C pH normal, alle Werte normal
D pH niedrig, pCO2 erhöht

113 **Was kennzeichnet die COPD?** ●●

A Eine chronische, nicht vollständig reversible Atemwegsobstruktion
B Eine vorübergehende, voll reversible Verengung
C Eine reine Herzerkrankung
D Eine Nierenentzündung

114 **Welcher Normwert gilt für den arteriellen CO2-Partialdruck (pCO2)?** ●●

A Etwa 5–15 mmHg
B Etwa 80–100 mmHg
C Etwa 120–140 mmHg
D Etwa 35–45 mmHg

115 **Was ist bei Hypoglykämie (BZ < 70 mg/dl, Patient wach) zu tun?** ●●

A Patient schlafen lassen
B Blutabnahme
C Sofort Insulin geben
D 20g schnell resorbierbare KH oral

116 **Was findet man typischerweise bei einer respiratorischen Alkalose (Hyperventilation)?** ●●●

A pH niedrig, pCO2 hoch
B pH hoch, HCO3 stark erhöht
C pH hoch, pCO2 erniedrigt
D alle Werte normal

117 **Welche Symptome sprechen für eine Lungenembolie?** ●●●

A Plötzliche Atemnot, atemabhängiger Brustschmerz und Tachykardie

B Über Stunden langsam zunehmende, dumpfe Schmerzen im Bauchraum

C Ein ausgeprägter, großflächiger Juckreiz der gesamten Haut

D Ausschließlich ein anhaltender, drückender Kopfschmerz

118 **Was ist das Bobath-Konzept in der Schlaganfallpflege?** ●●

A Dekubitusprophylaxe-Konzept

B Medikamentöse Therapie

C Kommunikationshilfe

D Rehabilitationskonzept: betroffene

119 **Warum ist eine ausgeprägte Hyperkaliämie (zu viel Kalium) gefährlich?** ●●●

A Sie verbessert die Herzfunktion

B Sie kann lebensbedrohliche Herzrhythmusstörungen auslösen

C Sie senkt nur harmlos den Blutdruck

D Sie hat keine Bedeutung

120 **Was ist HbA1c und was zeigt er?** ●●

A Durchschnittlicher Blutzuckerwert

B Aktueller Blutzucker

C Insulinspiegel

D Ketonkörper

7 Chirurgie

20 Fragen

121 **Welchen Nutzen hat die postoperative Frühmobilisation?**

(A) Sie erhöht das Risiko für eine Thrombose deutlich

(B) Sie dient rein kosmetischen und ästhetischen Zwecken

(C) Sie senkt Thrombose-, Pneumonie- und Ileusrisiko und fördert die Darmtätigkeit

(D) Sie ist nach einer Operation grundsätzlich untersagt

122 **Wann wird eine perioperative Antibiotikaprophylaxe typischerweise gegeben?**

(A) Kurz vor dem Hautschnitt (innerhalb der definierten Zeit vor OP-Beginn)

(B) Erst etwa zwei Tage nach der Operation als Nachbehandlung

(C) Grundsätzlich nie, da eine Prophylaxe nicht vorgesehen ist

(D) Ausschließlich dann, wenn nach der Operation Fieber auftritt

123 **Welche Zeichen weisen auf eine postoperative Nachblutung hin?**

(A) Ein verlangsamter Puls bei gleichzeitig hohem Blutdruck

(B) Eine trockene, warme Haut bei allgemeinem Wohlbefinden

(C) Tachykardie, Blutdruckabfall, plötzlich stark gefüllte Drainage, blasse kaltschweißige Haut

(D) Ausschließlich ein leichter Juckreiz im Wundbereich

124 **Welche Zeichen können auf eine tiefe Beinvenenthrombose (TVT) nach OP hinweisen?**

(A) Einseitige Schwellung, Spannungsgefühl, Überwärmung und Schmerz der Wade

(B) Beidseits auffällig kalte und blasse Beine ohne Schwellung

(C) Eine trockene, unauffällige Haut ganz ohne Beschwerden

(D) Ein anhaltender Juckreiz im Bereich des betroffenen Arms

125 **Was ist ein Kompartmentsyndrom?**

(A) Eine harmlose, rasch abklingende Schwellung des betroffenen Gewebes

(B) Ein bedrohlicher Druckanstieg in einer Muskelloge, der Durchblutung und Nerven schädigt

(C) Eine oberflächliche Rötung der Haut über der betroffenen Stelle

(D) Ein Verschluss der großen Halsvenen mit Blutrückstau zum Kopf

126 **Was gilt für die Einwilligung (Aufklärung) vor einer Operation?**

(A) Auf eine Einwilligung kann in aller Regel verzichtet werden

(B) Der Patient muss rechtzeitig aufgeklärt werden und informiert einwilligen

(C) Über den Eingriff entscheiden grundsätzlich die Angehörigen

(D) Die Aufklärung erfolgt erst nach dem Ende der Operation

127 **Was sind typische Komplikationen nach Appendektomie?** ●●

A Wundinfektion
B Reine Wundschmerzen
C Nur leichte Übelkeit
D Keine

128 **Wie lange sollen Patienten vor einer geplanten Operation in der Regel nüchtern sein?** ●●

A Klare Flüssigkeiten bis 2 h, feste Nahrung bis 6 h vorher
B Gar nicht nüchtern
C 24 Stunden komplett ohne alles
D Nur 30 Minuten vorher

129 **Worauf achtet die Pflege bei liegender Wunddrainage?** ●●

A Ausschließlich auf die Farbe und Sauberkeit der Bettwäsche des Patienten
B Auf Menge und Aussehen des Sekrets, Sog/Durchgängigkeit und Zeichen einer Nachblutung
C Auf gar nichts, da die Drainage sich vollständig selbst überwacht
D Nur einmal wöchentlich im Rahmen des routinemäßigen Verbandwechsels

130 **Was kennzeichnet eine Redon-Drainage?** ●●

A Eine geschlossene Saugdrainage mit Unterdruck (Sog)
B Eine offene Drainage ohne Sog
C Ein Blasenkatheter
D Eine Magensonde

131 **Wofür steht PONV in der perioperativen Pflege?** ●●

A Ein bestimmter gemessener Wert des arteriellen Blutdrucks
B Postoperative Übelkeit und Erbrechen (postoperative nausea and vomiting)
C Ein spezieller Verbandtyp für frische Operationswunden
D Eine bestimmte Lagerungsform des Patienten nach der Operation

132 **Warum müssen Patienten vor einer Narkose nüchtern sein?** ●●

A Vor allem, damit die geplante Operation insgesamt schneller ablaufen kann
B Hauptsächlich aus organisatorischen und wirtschaftlichen Kostengründen
C Um eine Aspiration (Übertritt von Mageninhalt in die Lunge) bei der Narkoseeinleitung zu vermeiden
D Das Nüchternsein ist aus medizinischer Sicht eigentlich unnötig

133 **Was ist bei der Versorgung eines frisch angelegten Stomas (z. B. Kolostomie) wichtig?** ●●●

A Die umgebende Haut möglichst kräftig und aggressiv reinigen und rubbeln
B Das Stoma vorsichtshalber abbinden, um Ausscheidungen zu verhindern
C Auf jegliche Beobachtung von Durchblutung und Hautzustand verzichten
D Farbe/Durchblutung des Stomas beurteilen, Haut schützen, dichte Versorgung wählen und Betroffene anleiten

134 **Welche Zeichen sprechen für eine Wundinfektion?** ●

A Eine blasse, kühle und trockene Umgebung der Wunde

B Eine auffällig rasche und komplikationslose Heilung

C Rötung, Schwellung, Überwärmung, Schmerz und ggf. eitriges Sekret

D Das vollständige Ausbleiben jeglicher Veränderung

135 **Wann wird eine Wunddrainage in der Regel entfernt?** ●●

A Unmittelbar und grundsätzlich sofort im Anschluss an die Operation

B Wenn die Fördermenge deutlich zurückgegangen ist (nach ärztlicher Anordnung)

C Grundsätzlich immer erst nach mehreren Wochen, unabhängig von der Fördermenge

D Niemals, da eine liegende Wunddrainage dauerhaft im Körper verbleibt

136 **Warum ist die Ein- und Ausfuhrbilanz postoperativ wichtig?** ●●

A Ausschließlich zur zusätzlichen Beschäftigung des Pflegepersonals

B Um Flüssigkeitshaushalt, Urinausscheidung und Drainageverluste zu überwachen

C Die Bilanz ist postoperativ ohne wesentliche Bedeutung

D Sie ist ausschließlich bei Kindern und Säuglingen erforderlich

137 **In welcher Reihenfolge verlaufen die Wundheilungsphasen?** ●●●

A Sie verläuft in einer einzigen, ununterbrochenen Heilungsphase

B Es bildet sich unmittelbar und ohne Zwischenstufen eine fertige Narbe

C Die Reinigungsphase steht ganz am Ende nach der Narbenbildung

D Exsudation/Reinigung, Granulation (Proliferation), Epithelisierung und Reifung (Remodeling)

138 **Welche Maßnahme dient postoperativ der Pneumonieprophylaxe?** ●●

A Möglichst flach liegen bleiben und die eigene Atmung bewusst ruhig und oberflächlich halten

B Das Rauchen zur Beruhigung erlauben und den Patienten möglichst viel allein im Bett ruhen lassen

C Atemübungen (z. B. Atemtrainer), Oberkörper hoch, Mobilisation und ausreichende Schmerztherapie für tiefe Atmung

D Ausschließlich langes und häufiges Schlafen ohne Mobilisation und ohne aktive Atemübungen

139 **Welche Prophylaxen sind postoperativ standardmäßig durchzuführen?** ●●

A Reine Frühmobilisation

B Thrombose-, Pneumonie-, Dekubitus- und Soorprophylaxe

C Antibiotika und Bettruhe

D Nur Schmerztherapie

140 **Was ist der postoperative Harnverhalt?** ●●

A Die Unfähigkeit, die volle Blase spontan zu entleeren

B Ein ungewöhnlich häufiges Wasserlassen in kleinen Mengen

C Eine bakterielle Infektion der Operationswunde

D Ein Verschluss des Darms mit fehlender Passage

8 Pädiatrie

20 Fragen

141 **Wie wird ein leicht bis mäßig dehydriertes Kind bei Durchfall bevorzugt behandelt?** ●●

- A Mit reinem Wasser in großen Mengen
- B Mit Nahrungskarenz über mehrere Tage
- C Mit oraler Rehydratationslösung (ORS)
- D Mit gesüßten Softdrinks

142 **Was sind Impfungen nach STIKO-Empfehlung und warum sind sie relevant?** ●●

- A Empfohlener Kinder-Impfkalender; Impfstatus bei Aufnahme prüfen
- B Impfplan nur für Erwachsene
- C Impfungen nur vor Auslandsreisen
- D Lediglich die Tetanusimpfung

143 **Was ist Kindesmisshandlung und welche Pflichten hat Pflegepersonal?** ●●●

- A Betrifft nur körperliche Gewalt
- B Nicht melden
- C Erst bei sichtbaren Verletzungen
- D Schutzauftrag nach §8a SGB VIII

144 **Was ist typisch für Keuchhusten (Pertussis)?** ●●

- A Anfallsartige, stakkatoartige Hustenattacken, für Säuglinge gefährlich
- B Ein juckender Ausschlag ganz ohne Husten
- C Nur ein leichter Schnupfen
- D Eine reine Magen-Darm-Erkrankung

145 **Was ist Neugeborenen-Gelbsucht (Neonataler Ikterus)?** ●●

- A Eine bakterielle oder virale Infektion des Neugeborenen
- B Physiologisch erhöhter Bilirubinwert (meist Tag 2–7)
- C Eine angeborene, genetisch bedingte Stoffwechselerkrankung
- D Eine ernsthafte Erkrankung der noch unreifen kindlichen Leber

146 **Was ist Rooming-in und welche Vorteile hat es?** ●●

- A Möglichkeit für Eltern, rund um die Uhr beim Kind zu bleiben
- B Ein hotelähnlicher Service für die begleitenden Eltern
- C Eine Möglichkeit, die ausschließlich auf der Intensivstation gilt
- D Ein Angebot, das ausschließlich den Müttern offensteht

147 **Was versteht man unter dem „Fremdeln“ im Säuglingsalter?** ●●

- A Eine Störung der Sprachentwicklung im Säuglingsalter
- B Eine behandlungsbedürftige Erkrankung des Säuglings
- C Das Reagieren mit Unbehagen auf fremde Personen (etwa ab dem 8. Monat)
- D Ein deutliches Zeichen einer emotionalen Vernachlässigung

148 **Was ist Pseudokrupp und wie wird er behandelt?** ●●

- A Virös bedingter
- B Echte Diphtherie
- C Bronchitis
- D Asthma-Anfall

149 **Was ist eine typische Ursache der Bronchiolitis/obstruktiven Bronchitis bei Säuglingen im Winter?** ●●●

- A Eine Nahrungsmittelallergie
- B Ein Sonnenbrand
- C Eine Verletzung
- D Das RS-Virus (RSV)

150 **Was sind die Pflichteinsatz-Stunden in der Pädiatrie laut GPA?** ●

- A 60h
- B 240h
- C 120h
- D 500h

151 **Was ist Exsikkose beim Kind?** ●●

- A Austrocknung (Dehydratation)
- B Eine hartnäckige Verstopfung mit ausbleibendem Stuhlgang
- C Ein deutliches Übergewicht des Kindes über der Altersnorm
- D Ein fieberhafter Infekt mit erhöhter Körpertemperatur

152 **Wozu dient die Vitamin-D-Prophylaxe im ersten Lebensjahr?** ●●

- A Zur Blutgerinnung
- B Zur Vorbeugung von Infektionen
- C Zur Vorbeugung von Rachitis (Knochenerweichung)
- D Zur Fiebersenkung

153 **Was ist bei Scharlach zu beachten?** ●●

- A Er wird durch Viren verursacht und braucht keine Behandlung
- B Er ist nicht ansteckend
- C Er tritt nur bei Erwachsenen auf
- D Er wird durch Streptokokken verursacht und mit Antibiotika behandelt

154 **Was gehört zur Unfallverhütung bei Kleinkindern?** ●

- A Steckdosen im Kinderzimmer bewusst offen und zugänglich lassen
- B Sicherungen wie Treppengitter und Steckdosensicherungen sowie das Wegräumen von Kleinteilen und Giftstoffen
- C Reinigungs- und Putzmittel in Reichweite der Kinder aufbewahren
- D Kleinkinder in der Nähe von Wasser unbeaufsichtigt spielen lassen

155 **Was sind motorische Entwicklungsmeilensteine im 1. Lebensjahr?** ●●

- A Laufen mit 6 Monaten
- B Kopfkontrolle 3 Mo., Drehen 5-6 Mo.
- C Sprechen mit 6 Monaten
- D Alle Kinder entwickeln sich gleich

156 **Warum ist das Wärmemanagement bei Frühgeborenen besonders wichtig?** ●●

(A) Weil sie schnell auskühlen und die Temperatur schlecht selbst regulieren können
(B) Weil sie überschüssige Wärme produzieren
(C) Weil Kälte ihnen nichts ausmacht
(D) Weil sie keine Temperaturüberwachung brauchen

157 **Was ist bei fiebersenkenden Medikamenten für Kinder wichtig?** ●●●

(A) Sie werden nach Körpergewicht und Alter dosiert (z. B. Paracetamol, Ibuprofen)
(B) Man gibt einfach die Erwachsenendosis
(C) Acetylsalicylsäure (ASS) ist das Mittel der Wahl
(D) Die Dosis spielt keine Rolle

158 **Was ist der APGAR-Score und wann wird er erhoben?** ●●

(A) Ernährungsbewertung
(B) Schmerzskala für Kinder
(C) Entwicklungsskala
(D) Beurteilung des Neugeborenen

159 **Was ist Entwicklungsfördernde Pflege auf der Neonatologie (NIDCAP)?** ●●●

(A) Reiz-reduzierende Entwicklungspflege
(B) Normale Pflege
(C) Ausschließlich Ernährungsaufbau
(D) Reine Inkubatorpflege

160 **Wann wird üblicherweise mit Beikost begonnen?** ●●

(A) Direkt nach der Geburt
(B) Etwa ab dem Beginn des 5. bis 7. Lebensmonats
(C) Erst ab dem 2. Lebensjahr
(D) Gar nicht im ersten Lebensjahr

9 Gynäkologie & Geburtshilfe

20 Fragen

161 **Was ist eine typische Indikation für eine Not-Sectio?**

A Wunsch nach schnellerer Geburt

B Leichte, unregelmäßige Wehen

C Akute Gefährdung des Kindes, z. B. pathologisches CTG mit drohender Hypoxie

D Alleinige Erschöpfung der Mutter

162 **Welche medikamentöse Therapie ist bei GDM Mittel der Wahl, wenn Ernährung nicht ausreicht?**

A Gar keine Therapie

B Cortison

C Orale Antidiabetika (Tabletten)

D Insulin – orale Antidiabetika sind in der Schwangerschaft nicht Mittel der Wahl

163 **Was ist das Ziel einer Tokolyse?**

A Die Wehentätigkeit zu hemmen und die Geburt hinauszuzögern

B Den Blutdruck zu senken

C Die Geburt einzuleiten

D Die Wehen zu verstärken

164 **Warum wird unter der Geburt ein CTG geschrieben?**

A Nur zur Dokumentation

B Um das Gewicht des Kindes zu bestimmen

C Um den Blutdruck der Mutter zu messen

D Um Wehentätigkeit und kindliche Herztöne zu überwachen und eine Sauerstoffunterversorgung früh zu erkennen

165 **Wofür stehen die Kriterien im APGAR-Score?**

A Aussehen, Puls, Größe, Atmung, Reaktion

B Alter, Puls, Gewicht, Atmung, Reflexe

C Atmung, Puls, Grundtonus, Aussehen (Hautfarbe), Reflexe

D Atmung, Position, Gewicht, Alter, Reflexe

166 **Wofür steht die Abkürzung HELLP?**

A Hypertonie, Ejektion, Laktat, Leukozyten, Puls

B Hämolyse, erhöhte Leberwerte (Elevated Liver enzymes), niedrige Thrombozyten (Low Platelets)

C Herz-, Leber- und Lungenproblem

D High Energy Low Level Pressure

167 **Welches ist ein typisches Leitsymptom des HELLP-Syndroms?**

A Schmerzen im linken Bein

B Ohrenschmerzen

C Halsschmerzen

D Rechtsseitiger Oberbauchschmerz (Leberkapselspannung)

168 **Ab wann spricht man von einer Frühgeburt?**

- A Jede Geburt per Sectio
- B Geburt nach der 42. SSW
- C Geburt vor der 40. SSW
- D Geburt vor abgeschlossener 37. SSW (vor 37+0)

169 **Was spricht für eine korrekte Anlegetechnik?**

- A Das Kind saugt nur ganz kurz
- B Die Mutter hat starke Schmerzen
- C Das Kind erfasst nur die Brustwarze
- D Das Kind erfasst Mamille und großen Teil des Warzenhofs, Lippen nach außen gestülpt

170 **Worauf muss das Neugeborene einer Mutter mit GDM nach der Geburt überwacht werden?**

- A Auf Hypoglykämie (Unterzucker)
- B Auf Fieber
- C Sofort auf Übergewicht
- D Auf Bluthochdruck

171 **In welcher Reihenfolge verlaufen die Geburtsphasen?**

- A Nachgeburt – Eröffnung – Austreibung
- B Austreibung – Eröffnung – Nachgeburt
- C Es gibt nur eine einzige Phase
- D Eröffnungsphase – Austreibungsphase – Nachgeburtsphase

172 **Welche sind sichere Zeichen des Geburtsbeginns?**

- A Vermehrter Appetit
- B Sodbrennen und Übelkeit
- C Regelmäßige, zunehmende Wehen, Blasensprung und Zeichnen
- D Nur Rückenschmerzen

173 **Was ist die einzige kausale Therapie des HELLP-Syndroms?**

- A Bettruhe
- B Abwarten bis zum Termin
- C Die Entbindung
- D Antibiotika

174 **Ist Stillen nach einem Kaiserschnitt möglich?**

- A Nein, grundsätzlich nicht
- B Erst nach sechs Wochen
- C Nur mit Medikamenten
- D Ja – möglich, oft aber anfangs erschwert und mit Unterstützung

175 **Warum wird bei drohender Frühgeburt Kortison gegeben?**

- A Zur Lungenreifeinduktion des Kindes (Surfactant-Bildung)
- B Zur Wehenhemmung
- C Gegen Schmerzen
- D Zur Blutdrucksenkung

176 **Welche Hormone steuern die Laktation?**

- A Östrogen und Testosteron
- B Cortisol und Thyroxin
- C Prolaktin (Milchbildung) und Oxytocin (Milchflussreflex)
- D Insulin und Adrenalin

177 **Worauf ist nach einer Sectio pflegerisch besonders zu achten?**

- A Nur auf die Wunde
- B Strikte Bettruhe für zwei Wochen
- C Sofortiges Abstillen
- D Konsequente Thromboseprophylaxe – das Risiko ist nach OP und im Wochenbett erhöht

178 **Wann wird das Screening auf Gestationsdiabetes (oGTT) durchgeführt?**

- A Immer im ersten Trimenon
- B In der 6. SSW
- C In der 24. bis 28. SSW
- D Erst nach der Geburt

179 **Wann wird die U1 durchgeführt?**

- A Direkt nach der Geburt
- B Nach sechs Wochen
- C Am 10. Lebenstag
- D Nur bei Auffälligkeiten

180 **Warum ist der Wärmeerhalt beim Neugeborenen so wichtig?**

- A Nur aus Komfortgründen
- B Das ist nur bei Frühgeborenen relevant
- C Neugeborene kühlen wegen großer Körperoberfläche und unreifer Thermoregulation schnell aus
- D Damit sie besser schlafen

10 Psychiatrie

20 Fragen

181 **Was ist Zwangsstörung (OCD)?** ●●●

A Persönlichkeitsstörung
B Psychose
C Zwangseinweisung
D Wiederkehrende aufdringliche

182 **Was ist De-Eskalation in der Psychiatrie?** ●●

A Fixierung sofort
B Aggression verstärken
C Medikamente zwangsweise
D Systematische Deeskalation

183 **Was besagt das bio-psycho-soziale Modell in der Psychiatrie?** ●

A Ausschließlich biologische Ursachen sind für die Entstehung entscheidend
B Psychische Störungen entstehen durch das Zusammenwirken biologischer, psychischer und sozialer Faktoren
C Ausschließlich die Erlebnisse der Kindheit prägen die Erkrankung
D Soziale Faktoren spielen für die Entstehung keinerlei Rolle

184 **Was ist ein Alkoholentzugsdelir (Delirium tremens)?** ●●●

A Eine lebensbedrohliche Entzugskomplikation mit Verwirrtheit, Zittern, Halluzinationen und vegetativen Symptomen
B Ein vorübergehender, im Grunde harmloser Kater nach Alkoholkonsum
C Eine leichte, rasch abklingende Kopfschmerzphase ohne weitere Folgen
D Ein völlig normaler und ungefährlicher Schlafzustand während des Entzugs

185 **Was bedeutet Einwilligungsfähigkeit im psychiatrischen Kontext?** ●●●

A Sie ist automatisch mit dem Erreichen der Volljährigkeit gegeben
B Die Fähigkeit, Art, Bedeutung und Tragweite einer Maßnahme zu verstehen und frei zu entscheiden
C Sie ist völlig gleichbedeutend mit der Geschäftsfähigkeit
D Sie liegt in der Zustimmung der nächsten Angehörigen

186 **Was ist eine Major Depression und welche Kernsymptome hat sie?** ●●

A Eine normale Traurigkeit als Reaktion auf einen Verlust
B Eine kurze, rasch vorübergehende Stimmungsschwankung
C Ein durch Überlastung entstandenes Burnout-Syndrom
D Depressive Stimmung, Interessenverlust und Antriebsminderung

187 **Welches ist ein Kennzeichen einer Abhängigkeitserkrankung?** ●●

A Gelegentlicher, gut kontrollierter Konsum

B Starkes Verlangen (Craving), Kontrollverlust und Entzugserscheinungen

C Ausschließlich körperliche Beschwerden ohne Verlangen

D Ein einmaliger Konsum

188 **Was ist das maligne neuroleptische Syndrom?** ●●●

A Eine völlig harmlose und vorübergehende Begleiterscheinung der Behandlung

B Eine seltene, lebensbedrohliche Reaktion auf Antipsychotika mit hohem Fieber, Muskelrigidität und Bewusstseinsstörung

C Eine besondere Form einer Angststörung mit ausgeprägter innerer Unruhe

D Eine allergische Reaktion der Haut mit Rötung und Juckreiz

189 **Was ist Milieutherapie in der Psychiatrie?** ●●●

A Therapeutische Gestaltung der gesamten Stationsumgebung

B Eine Form der Umwelttherapie mit Aufenthalten in der Natur

C Eine ausschließlich im Einzelsetting durchgeführte Therapie

D Eine reine Behandlung allein durch die Gabe von Medikamenten

190 **Was sollte man Patienten über die Wirkung von Antidepressiva (z. B. SSRI) erklären?** ●●

A Sie wirken sofort nach der ersten Tablette

B Sie machen grundsätzlich abhängig

C Die stimmungsaufhellende Wirkung setzt oft erst nach 1–3 Wochen ein

D Man kann sie jederzeit abrupt absetzen

191 **Was ist eine Borderline-Persönlichkeitsstörung?** ●●●

A Eine Form der Schizophrenie

B Eine Depression

C Instabile Identität

D Eine Angststörung

192 **Was ist Demenz und wie unterscheidet sie sich von Depression?** ●●●

A Demenz ist heilbar

B Demenz = organischer

C Depression ist schwerer

D Beide gleich

193 **Was ist das Ziel einer Krisenintervention?** ●●

A Die langfristige ambulante Psychotherapie vollständig zu ersetzen

B Kurzfristige Stabilisierung und Entlastung in einer akuten seelischen Ausnahmesituation

C Die sofortige Fixierung und Ruhigstellung des Betroffenen

D Die akute seelische Krise bewusst zu übergehen und abzuwarten

194 **Was gehört zum psychopathologischen Befund (Beobachtung psychischer Symptome)?** ●●●

A Ausschließlich die gemessene Körpertemperatur und die weiteren Vitalzeichen des Patienten

B Systematische Beschreibung von Bewusstsein, Orientierung, Affekt, Antrieb, Denken und Wahrnehmung

C Ausschließlich die im Labor bestimmten Blutwerte und bildgebenden Befunde

D Ausschließlich die vom Arzt gestellte Diagnose ohne jede eigene pflegerische Beobachtung

195 **Was ist bei einer akuten Intoxikation (z. B. Alkohol, Drogen) pflegerisch vorrangig?** ●●

A Vitalzeichen und Bewusstsein überwachen, Aspiration und Atemdepression vorbeugen

B Sofort und vorrangig ein ausführliches Deeskalationsgespräch führen

C Den betroffenen Patienten aktiv zum Aufstehen und Gehen zwingen

D Dem Patienten zur Stärkung zunächst reichlich Nahrung anbieten

196 **Was ist das Konzept der Psychoedukation?** ●●

A Ergotherapie

B Verhaltenstherapie

C Psychiatrie-Studium

D Strukturierte

197 **Was ist therapeutische Kommunikation in der Psychiatrie?** ●●

A Die gezielte Ablenkung des Patienten von seinen Problemen

B Empathische, wertschätzende und nicht-wertende Gesprächsführung

C Klare, direktive Anweisungen und Vorgaben an den Patienten

D Die reine Verabreichung der verordneten Medikamente

198 **Was ist der Unterschied zwischen Psychose und Neurose?** ●●

A Psychose = Realitätsverlust, Neurose = erhaltene Realitätsprüfung

B Beide Begriffe bezeichnen im Grunde denselben Zustand

C Eine Psychose verläuft grundsätzlich harmloser als eine Neurose

D Eine Neurose ist stets die deutlich schwerere Erkrankung

199 **Welchen therapeutischen Zweck hat eine klare Tagesstrukturierung?** ●

A Sie dient ausschließlich der organisatorischen Ordnung der Station

B Sie gibt Orientierung, Sicherheit und Halt und fördert Aktivierung und Selbstständigkeit

C Sie wirkt sich bei einer Depression eher schädlich aus

D Sie kann die Gabe von Medikamenten vollständig ersetzen

200 **Was regelt das PsychKG (in NRW) unter anderem?** ●●●

A Ausschließlich die Höhe und Auszahlung der Vergütung von Pflegekräften

B Voraussetzungen und Verfahren der Unterbringung und Behandlung bei erheblicher Selbst- oder Fremdgefährdung

C Ausschließlich Fragen des Datenschutzes im Bereich der Psychiatrie

D Ausschließlich die Ausbildung und Weiterbildung von Fachärzten

11 Psychologie & Kommunikation

20 Fragen

201 **Was bedeutet Kongruenz (Echtheit) in der Gesprächsführung?** ●●

(A) Das äußere Verhalten stimmt mit dem inneren Erleben überein (Echtheit)

(B) Man verstellt sich im Gespräch bewusst und gezielt

(C) Man äußert grundsätzlich das Gegenteil des Gemeinten

(D) Man schweigt im Gespräch grundsätzlich und dauerhaft

202 **Welche drei Grundhaltungen kennzeichnen die personenzentrierte Gesprächsführung nach Rogers?** ●●●

(A) Autorität, Distanz, Kontrolle

(B) Belehrung, Wertung, Ratschlag

(C) Empathie, Kongruenz (Echtheit) und bedingungslose Wertschätzung

(D) Schweigen, Ignorieren, Ablenken

203 **Was ist im Umgang mit Menschen mit fortgeschrittener Demenz oft sinnvoll?** ●●

(A) Auf Fakten bestehen und widersprechen

(B) Möglichst schnell und kompliziert sprechen

(C) Ständiges Abfragen von Datum und Ort

(D) Einfache Sprache, Blickkontakt und Gefühle aufgreifen statt zu korrigieren

204 **Wozu dient Biografiearbeit in der Pflege?** ●●

(A) Zur reinen Sammlung von Daten ohne weiteren praktischen Nutzen

(B) Zur Überwachung und Kontrolle des Verhaltens der Patienten

(C) Die Lebensgeschichte zu nutzen, um individuell, sinnstiftend und bedürfnisorientiert zu pflegen

(D) Um vergangene Ereignisse im Leben zu bewerten und zu beurteilen

205 **Was ist bei der Deeskalation aggressiver Situationen hilfreich?** ●●

(A) Die eigene Lautstärke steigern und Drohungen aussprechen

(B) Ruhig bleiben, zuhören, Abstand und Sicherheit wahren und den Menschen ernst nehmen

(C) Den betroffenen Menschen gezielt reizen und provozieren

(D) Ihn umgehend und ohne weitere Deeskalation zu fixieren

206 **Was ist ein Vorurteil bzw. Stereotyp?** ●●

(A) Eine vorgefasste, verallgemeinernde Bewertung ohne ausreichende Prüfung

(B) Eine gesicherte und fachlich belegte medizinische Diagnose

(C) Ein im Pflegeprozess formuliertes konkretes Pflegeziel

(D) Eine objektive, mit Messgeräten erhobene Beobachtung

207 **Was besagt das Axiom 'Man kann nicht nicht kommunizieren' (Watzlawick)?** ●●

A Nur bewusst gesprochene Worte gelten als echte Kommunikation

B Jedes Verhalten hat Mitteilungscharakter – auch Schweigen oder Wegsehen wirkt kommunikativ

C Die Kommunikation ist für das Miteinander im Grunde unwichtig

D Ausschließlich schriftlich Festgehaltenes zählt als Kommunikation

208 **Was ist Gewaltfreie Kommunikation (GFK) nach Rosenberg?** ●●

A 4 Schritte: Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis, Bitte

B Schweigen bei Konflikten

C Konfliktmanagement-Kurs

D Kommunikation ohne Schreien

209 **Was beschreibt der 'erste Eindruck' (Primäreffekt)?** ●●

A Er trifft grundsätzlich immer zu und ist zuverlässig zutreffend

B Er spielt für die weitere Wahrnehmung praktisch keine Rolle

C Frühe Informationen prägen die Wahrnehmung stark und können zu Fehleinschätzungen führen

D Er bildet sich erst nach mehreren Wochen der näheren Bekanntschaft

210 **Was besagt das 4-Ohren-Modell nach Schulz von Thun?** ●●

A 4 Fehler in der Kommunikation

B 4 Phasen der Kommunikation

C Jede Nachricht hat 4 Seiten

D 4 Kommunikationsstile

211 **Was unterscheidet problemorientiertes von emotionsorientiertem Coping?** ●●●

A Problemorientiert verändert die Situation, emotionsorientiert reguliert die eigenen Gefühle

B Beide Bewältigungsformen sind vollständig identisch und unterscheiden sich nicht

C Jede Form der Bewältigung ist grundsätzlich schädlich für den Betroffenen

D Ausschließlich Medikamente können bei der Bewältigung überhaupt helfen

212 **Was bedeutet Empathie in der Pflege?** ●

A Ein Mitgefühl, das die Pflegekraft handlungsunfähig macht

B Die Fähigkeit, sich in die Gefühle und Sichtweise des anderen einzufühlen

C Eine grundsätzliche Gleichgültigkeit gegenüber dem Patienten

D Das konsequente Durchsetzen der eigenen Meinung

213 **Was kennzeichnet eine offene Frage?** ●

A Sie lädt zum ausführlichen Erzählen ein (z. B. 'Wie geht es Ihnen?')

B Sie kann nur mit Ja oder Nein beantwortet werden

C Sie ist immer suggestiv

D Sie unterbricht das Gespräch

214 **Was beschreibt selektive Wahrnehmung?** ●●

(A) Die Umgebung wird stets vollständig objektiv wahrgenommen

(B) Die menschliche Wahrnehmung verläuft grundsätzlich fehlerfrei

(C) Wir nehmen bevorzugt wahr, was zu unseren Erwartungen und Interessen passt – anderes wird ausgeblendet

(D) Der Mensch nimmt seine Umgebung im Grunde gar nicht wahr

215 **Was gehört zur nonverbalen Kommunikation?** ●

(A) Die Rechtschreibung und die Grammatik des Geschriebenen

(B) Mimik, Gestik, Körperhaltung, Blickkontakt und Tonfall

(C) Ausschließlich der reine inhaltliche Sinn der gesprochenen Worte

(D) Die verwendete E-Mail-Adresse und Telefonnummer

216 **Was bedeutet professionelle Abgrenzung?** ●●

(A) Patienten bewusst grob und abweisend zu behandeln

(B) Sich emotional so abzugrenzen, dass man empathisch bleibt, ohne selbst auszubrennen

(C) Grundsätzlich keinerlei Empathie und Mitgefühl zu zeigen

(D) Möglichst gar nicht mit den Patienten ins Gespräch zu gehen

217 **Wie geht man konstruktiv mit einem Teamkonflikt um?** ●●

(A) Den Konflikt bewusst übergehen und einfach aussitzen

(B) Das Problem sachlich ansprechen, aktiv zuhören und gemeinsam nach Lösungen suchen

(C) Die vermeintlich Schuldigen öffentlich beim Namen nennen

(D) Die Kommunikation mit dem Gegenüber ganz abbrechen

218 **Was ist eine Ich-Botschaft in der Kommunikation?** ●●

(A) Ein deutlicher Vorwurf an den anderen ('Du machst das immer falsch')

(B) Eine klare Anweisung oder ein Befehl an das Gegenüber

(C) Bewusstes Schweigen, um dem anderen keine Angriffsfläche zu bieten

(D) Das Ausdrücken eigener Wahrnehmung und Gefühle ('Ich habe den Eindruck, dass...')

219 **Was meint 'bedingungslose Wertschätzung' (Akzeptanz)?** ●●

(A) Die vorbehaltlose Zustimmung zu jedem gezeigten Verhalten

(B) Die Akzeptanz ausschließlich freundlicher und netter Patienten

(C) Die Bewertung der Person nach der eigenen Sympathie

(D) Den Menschen als Person annehmen, unabhängig von Verhalten oder Meinung

220 **Was bedeutet Adhärenz (Compliance) in der Behandlung?**

(A) Das Ausmaß, in dem das Verhalten mit den gemeinsam vereinbarten Empfehlungen übereinstimmt

(B) Die reine ärztliche Anordnung ohne Beteiligung des Patienten

(C) Die grundsätzliche Ablehnung jeglicher Behandlung durch den Patienten

(D) Eine unerwünschte Nebenwirkung der verordneten Medikamente

12 Altenpflege & Geriatrie

20 Fragen

221 **Wie kann sich eine Depression im Alter von einer Demenz unterscheiden?** ●●●

A Bei der Depression klagen Betroffene oft selbst über die Beschwerden, während sie bei Demenz eher überspielt werden

B Depression und Demenz sind in ihrem Erscheinungsbild vollständig identisch

C Eine Depression tritt im höheren Lebensalter grundsätzlich nicht mehr auf

D Eine Demenz ist bei rechtzeitiger Behandlung in aller Regel vollständig heilbar

222 **Wie geht man mit herausforderndem Verhalten bei Demenz um?** ●●

A Man diskutiert mit der Person und korrigiert sie konsequent

B Man übergeht die Person und ihr Verhalten weitgehend

C Man begegnet ihr mit Strenge und deutlichem Druck

D Man sucht nach Auslösern, bleibt ruhig und wertschätzend und geht auf Bedürfnisse ein

223 **Welche Fraktur ist bei sturzgefährdeten älteren Menschen mit Osteoporose besonders häufig und folgenreich?** ●●

A Eine Zehenfraktur

B Eine Nasenbeinfraktur

C Eine Rippenprellung

D Die hüftnahe (Schenkelhals-)Fraktur

224 **Was ist Validation nach Naomi Feil in der Altenpflege?** ●●

A Schmerzmessung

B Kommunikationsmethode

C Lagerungstechnik

D Wundbehandlung

225 **Wozu dienen Kurzzeit- und Verhinderungspflege?** ●●

A Zur vorübergehenden Entlastung pflegender Angehöriger bzw. zur Überbrückung

B Der dauerhaften Unterbringung im Pflegeheim

C Ausschließlich der medizinischen Rehabilitation

D Der Finanzierung von Umbaumaßnahmen in der Wohnung

226 **Was regelt das Betreuungsrecht und wann greift es?** ●●●

A Rechtliche Betreuung für nicht mehr selbst handlungsfähige Volljährige

B Den Abschluss und die Inhalte eines Heimvertrags

C Die Vormundschaft für noch minderjährige Kinder

D Die Feststellung und Einstufung des Pflegegrades

227 **Was ist Sterbebegleitung und welche Zeichen des Sterbens sind zu beobachten?** ●●

A Aktive Begleitung: Mundpflege

B Arzt anrufen und warten

C Sofort Reanimation

D Nichts tun

228 **Was ist typisch für die Alzheimer-Demenz?** ●●

A Ein plötzlicher Beginn mit Verschlechterung über Nacht

B Ausschließlich körperliche Beschwerden ohne geistige Zeichen

C Ein schleichender Beginn mit fortschreitendem Verlust von Gedächtnis und Orientierung

D Eine bei rechtzeitiger Behandlung vollständige Heilbarkeit

229 **Wozu dient die Braden-Skala?** ●●

A Zur Messung des Blutdrucks

B Zur Bestimmung des Body-Mass-Index

C Zur Einschätzung des Dekubitusrisikos

D Zur Messung der Sehschärfe

230 **Was ist das Wundmanagement bei chronischen Wunden im Alter?** ●●●

A Systematische feuchte Wundversorgung

B Trockene Wundabdeckung mit Mull

C Pflaster draufkleben

D Tägliches Ausspülen mit Alkohol

231 **Was ist das SGB XI und welche Leistungen gibt es?** ●●●

A Arbeitslosenversicherung

B Rentenversicherung

C Krankenversicherung

D Soziale Pflegeversicherung

232 **Was ist der Expertenstandard Sturzprophylaxe?** ●●

A Die Anordnung von durchgehender und strenger Bettruhe

B Die vorbeugende Fixierung der sturzgefährdeten Person

C Risikoeinschätzung und individuelle Sturzpräventionsmaßnahmen

D Das durchgehende Hochstellen der seitlichen Bettgitter

233 **Was versteht man unter Polypharmazie und warum ist sie im Alter riskant?** ●●●

A Die Einnahme ausschließlich eines einzigen Medikaments

B Der vollständige Verzicht auf jegliche Medikamenteneinnahme

C Die gleichzeitige Einnahme vieler Medikamente mit erhöhtem Risiko für Wechsel- und Nebenwirkungen

D Eine besondere, speziell abgestimmte Form der Ernährung

234 **Was ist Biografiearbeit und warum ist sie in der Altenpflege wichtig?** ●●

A Eine möglichst lückenlose pflegerische Verlaufsdokumentation

B Die vollständige medizinische Vorgeschichte des Patienten

C Die Erhebung der Erkrankungen innerhalb der Familie

D Lebensgeschichte, Gewohnheiten und prägende Erlebnisse erfassen

235 **Was ist das Neue Begutachtungsassessment (NBA)?** ●●

A Begutachtungsinstrument
B Ein Pflegeplan
C Eine Pflegediagnose
D Ein Labortest

236 **Was ist bei einem plötzlich verwirrten älteren Menschen zu bedenken?** ●●

A Das ist im Alter normal und erfordert keine weitere Beachtung
B Es könnte ein akutes Delir mit behandelbarer Ursache sein (z. B. Infekt, Exsikkose, Medikamente)
C Es handelt sich grundsätzlich um eine unheilbare Demenz
D Man sollte den Betroffenen einfach in Ruhe weiterschlafen lassen

237 **Was ist bei der Hautpflege alter Menschen zu beachten?** ●

A Die Haut ist dünner und trockener, daher schonende Reinigung und rückfettende Pflege
B Möglichst heiß und lange baden
C Häufiges Waschen mit stark entfettender Seife
D Die Haut braucht keine besondere Pflege

238 **Was ist das Heimgesetz NRW (WTG) und was regelt es?** ●●●

A Wohn- und Teilhabegesetz
B Regelung der Pflegeausbildung
C Krankenhaus-Gesetze
D Ambulante Pflege

239 **Warum sind alte Menschen besonders von einer Exsikkose (Austrocknung) bedroht?** ●●

A Weil sie zu viel trinken
B Weil das Durstempfinden im Alter nachlässt und weniger getrunken wird
C Weil sie mehr Flüssigkeit speichern
D Weil Wasser im Alter schädlich ist

240 **Was ist Kinästhetik und ihre Bedeutung in der Altenpflege?** ●●

A Bewegungslehre
B Ergotherapie
C Physiotherapie
D Sporttherapie

13 Palliativpflege

20 Fragen

241 **Was versteht man unter palliativer Sedierung?** ●●●

A Die gezielte Herbeiführung des Todes

B Den kompletten Verzicht auf jede Medikation

C Das kontrollierte Herabsetzen des Bewusstseins zur Linderung sonst unstillbarer Symptome

D Eine Vollnarkose zur Operation

242 **Was unterscheidet ein stationäres Hospiz von einer Palliativstation?** ●

A Hospiz ist Teil des Krankenhauses

B Palliativstation ist im Krankenhaus, Hospiz ist eigenständig

C Beide sind identisch

D Hospiz nur für Kinder

243 **Was bedeutet eine Therapiezieländerung am Lebensende?** ●●

A Maximaltherapie um jeden Preis

B Wechsel von kurativem zu lindernd-palliativem Ziel

C Therapieabbruch ohne Begleitung

D Aktive Sterbehilfe

244 **Welche Nebenwirkung tritt regelhaft unter Opioiden auf und muss prophylaktisch behandelt werden?** ●●

A Durchfall

B Haarausfall

C Obstipation

D Fieber

245 **Was ermöglicht die spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV) vielen Menschen?** ●●

A Ausschließlich eine stationäre Behandlung

B Ein Sterben in der vertrauten häuslichen Umgebung

C Einen Verzicht auf jede Symptomkontrolle

D Nur die Versorgung im Krankenhaus

246 **Welche Phasen der Trauer beschrieb Verena Kast?** ●●●

A Zuerst Leugnen, dann Feilschen, danach Handeln und schließlich Vergessen

B Eine einzige, für alle Menschen immer gleich verlaufende Trauerphase

C Nicht-wahrhaben-Wollen, aufbrechende Emotionen, Suchen/Sich-Trennen, neuer Selbst- und Weltbezug

D Ein fester Ablauf aus anfänglichem Schock, Koma und darauf folgender Heilung

247 **Wie definiert die WHO Palliative Care?** ●

A Verbesserung der Lebensqualität bei lebensbedrohlicher Erkrankung

B Heilung der Grunderkrankung

C Ausschließlich Sterbebegleitung

D Beschränkt auf Schmerztherapie

248 **Was ist in der Sterbephase bei der Mundpflege besonders wichtig?**

A Reichliche Flüssigkeitszufuhr erzwingen
B Mundpflege vermeiden
C Feuchthalten der Schleimhäute und Komfort
D Ausschließlich Zähneputzen

249 **Was regelt eine Vorsorgevollmacht?**

A Sie bevollmächtigt eine benannte Vertrauensperson, im Ernstfall für einen zu entscheiden
B Sie legt nur die Bestattungsart fest
C Sie ersetzt das Testament
D Sie ist nur für Ärzte bindend, nicht für Angehörige

250 **Was gehört zur spirituellen Begleitung am Lebensende?**

A Ausschließlich medikamentöse Therapie
B Nur die Regelung finanzieller Fragen
C Das Eingehen auf Sinnfragen, Glauben und persönliche Werte, ggf. mit Seelsorge
D Das Ignorieren religiöser Bedürfnisse

251 **Wie begegnet man terminaler Unruhe (Delir) in der Sterbephase?**

A Den Patienten allein und im Dunkeln lassen
B Reizarme, ruhige Umgebung, Präsenz und ärztlich angeordnete Symptomlinderung
C Ihn grundsätzlich fixieren
D Jede Zuwendung vermeiden

252 **Welche Anzeichen deuten auf die beginnende Finalphase (nahender Tod) hin?**

A Steigender Appetit und mehr Energie
B Anhaltend hoher Blutdruck
C Marmorierte, kühle Haut, veränderte Atmung und zunehmende Schwäche
D Deutliche Gewichtszunahme

253 **Womit lindert man Übelkeit und Erbrechen in der Palliativversorgung?**

A Mit möglichst viel Nahrung auf einmal
B Mit Antiemetika nach ärztlicher Anordnung, angepasst an die Ursache
C Ausschließlich mit strikter Bettruhe
D Durch tagelanges Nüchternlassen

254 **Wie ist die Sorge vor Atemdepression bei korrekt titrierten Opioiden in der Palliativversorgung einzuordnen?**

A Sehr häufig auftretend, weshalb Opioide grundsätzlich gemieden werden
B In praktisch allen Fällen unmittelbar tödlich verlaufend
C Bei sachgerechter Titration selten - Symptomlinderung steht im Vordergrund
D Ausschließlich bei Kindern und Jugendlichen zu beobachten

255 **Was gehört zur würdevollen Versorgung eines Verstorbenen?** ●●

A Waschen, Herrichten und Beachten kultureller bzw. religiöser Wünsche

B Möglichst schnelles Abtransportieren ohne Rücksicht

C Sofortiges Entfernen aller persönlichen Gegenstände

D Verzicht auf jede Körperpflege

256 **Was ist bei der Trauerbegleitung von Angehörigen wichtig?** ●●

A Trauer zulassen und individuell begleiten

B Trauer schnell beenden

C Kontakt vermeiden

D Ausschließlich mit Medikamenten behandeln

257 **Welche Medikamente werden bei neuropathischen Schmerzen häufig ergänzend (als Ko-Analgetika) eingesetzt?** ●●●

A Nur klassische Schmerzmittel wie Paracetamol

B Ausschließlich Opioide

C Bestimmte Antidepressiva und Antikonvulsiva

D Reine Vitaminpräparate

258 **Warum ist es wichtig, Angehörigen Zeit zum Abschied am Verstorbenen zu geben?** ●

A Damit die Formalitäten schneller gehen

B Aus rein rechtlichen Gründen

C Weil ein bewusster Abschied die Trauerverarbeitung unterstützt

D Es ist eigentlich unwichtig

259 **Welches ist ein unsicheres Todeszeichen?** ●●

A Die eingetretene und deutlich ausgeprägte Totenstarre des Körpers

B Die sichtbaren Totenflecken an den tiefliegenden Körperpartien

C Die einsetzenden Fäulnis- und Zersetzungserscheinungen

D Fehlende Atmung und fehlender Puls

260 **Was ist bei kultur- und religionssensibler Sterbebegleitung wichtig?** ●●

A Allen dieselben Rituale vorzugeben

B Individuelle religiöse und kulturelle Bedürfnisse zu erfragen und zu respektieren

C Rituale generell abzulehnen

D Nur die eigene Weltanschauung gelten zu lassen

14 Rehabilitation

20 Fragen

261 **Was ist das zentrale Ziel von Leistungen zur Teilhabe (SGB IX)?** ●●

A Selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben

B Klinikaufenthalt verlängern

C Pflegegrad erhöhen

D Medikamente reduzieren

262 **Wofür steht die Phase B im Phasenmodell der neurologischen Reha?** ●●●

A Für die abschließende berufliche Wiedereingliederung

B Für die Frührehabilitation schwer betroffener Patienten

C Für die reine Nachsorge zu Hause

D Für die medikamentöse Akutbehandlung

263 **Was ist ein Grundprinzip des Bobath-Konzepts?** ●●

A Betroffene Seite vernachlässigen

B Strikte Immobilisation

C Training nur der gesunden Seite

D Einbeziehung der betroffenen Körperseite

264 **Was bedeutet Ressourcenorientierung in der rehabilitativen Pflege?** ●

A Defizite betonen

B Vorhandene Fähigkeiten erkennen und fördern

C Alle Tätigkeiten abnehmen

D Den Pflegeaufwand reduzieren

265 **Worauf bezieht sich das ICF-Modell der WHO?** ●●

A Die ärztliche Diagnoseliste

B Der Medikationsplan

C Funktionsfähigkeit, Aktivität und Teilhabe

D Die Behandlungskosten

266 **Was misst der Barthel-Index?** ●●

A Den Blutdruck

B Ausschließlich das Sturzrisiko

C Die Selbstständigkeit bei Alltagsaktivitäten (ADL)

D Die Nahrungsaufnahme in Kalorien

267 **Wofür wird das Konzept der Basalen Stimulation eingesetzt?** ●●

A Förderung von Wahrnehmung und Kommunikation bei beeinträchtigten Menschen

B Eine Behandlung mit gezielt eingesetztem Reizstrom zur Muskelstimulation

C Die reine Gabe von Schmerzmitteln zur Linderung von Beschwerden

D Die fachgerechte Versorgung und Reinigung von Wunden

268 **Wie kommuniziert man am besten mit einem Menschen mit Aphasie?** ●●

A Möglichst schnell und viel auf einmal sprechen

B Alle Sätze für den Patienten zu Ende sprechen

C Geduldig, in kurzen einfachen Sätzen und mit nonverbalen Hilfen

D Kommunikation ganz vermeiden

269 **Was gehört zur Stumpfpflege nach einer Amputation?** ●●

A Den Stumpf möglichst nicht berühren

B Tägliche Hautinspektion, Reinigung und fachgerechtes Wickeln zur Stumpfformung

C Nur einmal wöchentlich kontrollieren

D Sofort dauerhaft die Prothese tragen

270 **In welcher Reihenfolge kleidet man einen Menschen mit Halbseitenlähmung an?** ●●

A Zuerst die gesunde Seite

B Zuerst die betroffene (gelähmte) Seite

C Die Reihenfolge ist egal

D Kleidung immer nur über den Kopf

271 **Was kennzeichnet aktivierend-therapeutische Pflege in der Rehabilitation?** ●●

A Therapeutische Prinzipien in Pflegehandlungen integrieren

B Vollständige Übernahme aller Tätigkeiten

C Reine Beobachtung ohne Eingreifen

D Strikte Bettruhe

272 **Was kennzeichnet das Konzept der Kinästhetik?** ●●

A Vollständiges Abnehmen jeder Bewegung

B Passives Durchbewegen ohne Beteiligung

C Bewegung ausschließlich über Hilfsmittel

D Bewegungsförderung durch angeleitete Eigenbewegung unter Nutzung vorhandener Ressourcen

273 **Was besagt der sozialrechtliche Grundsatz „Reha vor Pflege“?** ●●

A Pflege ist immer günstiger als Rehabilitation

B Reha ist nur für junge Menschen vorgesehen

C Rehabilitation hat Vorrang, um Pflegebedürftigkeit zu vermeiden oder zu mindern

D Pflegebedürftige haben keinen Reha-Anspruch

274 **Wer gehört typischerweise zum interprofessionellen Reha-Team?** ●

A Ausschließlich Pflegekräfte gemeinsam mit dem Reinigungsdienst

B Ausschließlich die behandelnden Ärzte und die Klinikverwaltung

C Ausschließlich die nahen Angehörigen des Patienten

D Pflege, Ärzte, Physio-/Ergotherapie, Logopädie, Sozialdienst

275 **Was ist ein Hauptziel der geriatrischen Rehabilitation?**

A Die vollständige Heilung sämtlicher bestehender Erkrankungen

B Erhalt von Selbstständigkeit und Vermeidung von Pflegebedürftigkeit

C Die dauerhafte Versorgung des Patienten in der Klinik

D Die gezielte Reduzierung der sozialen Kontakte

276 **Wer trägt in der Regel die Reha nach einem Arbeitsunfall?**

A Die gesetzliche Pflegekasse des betroffenen Patienten

B Das örtlich zuständige Sozialamt der Gemeinde

C Die private Haftpflichtversicherung des Verunfallten

D Die gesetzliche Unfallversicherung (Berufsgenossenschaft)

277 **Was ist eine Anschlussrehabilitation (AHB)?**

A Eine dauerhafte ambulante Versorgung im häuslichen Umfeld

B Ein Kuraufenthalt ganz ohne medizinische Notwendigkeit

C Ein Aufenthalt in einem Hospiz in der letzten Lebensphase

D Reha unmittelbar nach einem Krankenhausaufenthalt

278 **Was ist ein zentrales Ziel der Ergotherapie?**

A Ausschließlich das gezielte Training der Muskelkraft

B Ausschließlich das Üben des Sprechens und der Sprache

C Die Handlungsfähigkeit und Selbstständigkeit im Alltag (ADL) wiederherstellen

D Die Verabreichung der ärztlich verordneten Medikamente

279 **Welcher Grundsatz gilt im deutschen Sozialrecht (SGB)?**

A Reha vor Pflege

B Pflege vor Reha

C Reha statt Pflege immer

D Pflege schließt Reha aus

280 **In welcher Reihenfolge zieht man einen Menschen mit Halbseitenlähmung aus?**

A Zuerst die gesunde Seite ausziehen

B Zuerst die betroffene Seite ausziehen

C Immer beide Arme gleichzeitig

D Die Reihenfolge ist unwichtig

15 Anatomie: Herz & Kreislauf

20 Fragen

281 **Was bewirkt eine Aktivierung des Sympathikus?** ●●●

A Pulssenkung und enge Pupillen
B Verstärkte Verdauung
C Pulsanstieg, weite Pupillen, weite Bronchien
D Schlaf und Erholung

282 **Was passiert in der Diastole?** ●

A Auswurf in die Aorta
B Maximale Kontraktion
C Erschlaffung und Füllung der Kammern
D Sprengung der Klappen

283 **Was misst die Pulsoxymetrie?** ●

A Den arteriellen Blutdruck über einen Sensor am Finger
B Den Gehalt an Kohlendioxid in der ausgeatmeten Luft
C Die Sauerstoffsättigung und Pulsfrequenz
D Unmittelbar und direkt die Atemfrequenz des Patienten

284 **Was bedeutet Bradykardie?** ●

A Herzfrequenz unter 60/min
B Herzfrequenz über 100/min
C Unregelmäßiger Puls
D Blutdruckabfall

285 **Wie heißt die Muskelschicht des Herzens?** ●

A Myokard
B Endokard
C Epikard
D Perikard

286 **Warum ist die korrekte Pulskontrolle pflegerisch wichtig?** ●

A Zur Beurteilung von Frequenz, Rhythmus und Kreislaufstabilität
B Zur Berechnung der Medikamentendosis
C Zur Bestimmung des Blutzuckers
D Zur Hautpflege

287 **Welche Klappe trennt die linke Kammer von der Aorta?** ●●

A Pulmonalklappe
B Aortenklappe
C Mitralklappe
D Trikuspidalklappe

288 **Welche Vene führt nährstoffreiches Blut vom Darm zur Leber?** ●●●

A Untere Hohlvene
B Pfortader (V. portae)
C Lebervene
D Milzarterie

289 **Wie berechnet sich das Herzzeitvolumen (HZV)?** ●●●

- A Blutdruck × Puls
- B Herzfrequenz ÷ Schlagvolumen
- C Systole − Diastole
- D Schlagvolumen × Herzfrequenz

290 **Welches Gefäß ist die größte Arterie des Körpers?** ●

- A Aorta
- B Obere Hohlvene
- C Pulmonalvene
- D A. carotis

291 **Wohin pumpt die rechte Herzhälfte das Blut?** ●●

- A In den Körperkreislauf
- B In die Aorta
- C In die Koronararterien
- D In den Lungenkreislauf

292 **Was gilt grundsätzlich für Arterien?** ●

- A Sie führen Blut vom Herzen weg
- B Sie führen immer sauerstoffarmes Blut
- C Sie führen Blut zum Herzen hin
- D Sie führen nur Lymphe

293 **Was ist die Systole?** ●

- A Erschlaffungs- und Füllungsphase
- B Ruhephase des Sinusknotens
- C Klappenschluss der Venen
- D Anspannungs- und Auswurfphase der Kammern

294 **Welche Funktion haben Venenklappen?** ●●

- A Den Rückfluss des Blutes verhindern
- B Blut beschleunigen
- C Sauerstoff binden
- D Den Blutdruck messen

295 **Welche Klappe liegt zwischen rechtem Vorhof und rechter Kammer?** ●●

- A Mitralklappe
- B Trikuspidalklappe
- C Aortenklappe
- D Pulmonalklappe

296 **Wie hoch ist der normale Ruhepuls eines Erwachsenen?** ●

- A 30–50/min
- B 100–140/min
- C 140–180/min
- D 60–100/min

297 **Welche Klappentypen gibt es im Herzen?** ●●

- A Segelklappen und Sehnenfäden
- B Segelklappen (AV) und Taschenklappen
- C Venenklappen und Lymphklappen
- D Ringklappen

298 **Welche Gefäße versorgen den Herzmuskel selbst mit Blut?** ●●

- A Die Lungenvenen
- B Die Hohlvenen
- C Die Koronararterien (Herzkranzgefäße)
- D Die Halsschlagadern

299 **Was bezeichnet der QRS-Komplex im EKG?** ●●●

- A Vorhoferregung
- B Kammerrepolarisation
- C Eine Pause
- D Kammererregung (Depolarisation)

300 **Wie heißen die beiden oberen Herzhöhlen?** ●

- A Ventrikel (Kammern)
- B Klappen
- C Septen
- D Vorhöfe (Atrien)

Lösungsschlüssel & Erklärungen

Richtige Antwort und kurze Begründung zu jeder Frage.

Generalistische Ausbildung & Recht

1	B	Staatliche Abschlussprüfung §§15-25 PflAPrV: 1. Schriftlich (3 Klausuren, 5h gesamt), 2. Mündlich (30-45 Min.), 3. Praktisch (im Vertiefungseinsatz).
2	D	6-stufiger Pflegeprozess: 1.Assessment 2.Pflegediagnose 3.Pflegeziele 4.Maßnahmen planen 5.Durchführen 6.Evaluation.
3	D	Evaluation: systematisch prüfen ob Ziele erreicht. Wenn nein → Ursachen analysieren, Plan ändern. Evaluation ist kontinuierlich.
4	A	Expertenstandards des Deutschen Netzwerks für Qualitätsentwicklung in der Pflege (DNQP) sind wissenschaftlich fundierte, bundesweite Standards zu zentralen Themen wie Dekubitus-, Sturz- und Schmerzmanagement. Sie definieren fachlich anerkannte Qualitätsniveaus.
5	B	Die Ausbildung umfasst insgesamt rund 4600 Stunden: etwa 2100 Stunden theoretischen und praktischen Unterricht an der Pflegeschule sowie etwa 2500 Stunden praktische Ausbildung in den Einsatzbereichen.
6	A	Die Pflichteinsätze umfassen die stationäre Akutpflege (Krankenhaus), die stationäre Langzeitpflege (z. B. Pflegeheim), die ambulante Pflege sowie je einen Einsatz in der pädiatrischen und der psychiatrischen Versorgung – so wird die generalistische Breite abgedeckt.
7	C	Der generalistische Abschluss „Pflegefachfrau/Pflegefachmann“ ist EU-weit anerkannt (automatische Anerkennung nach EU-Berufsanerkennungsrichtlinie). Das erleichtert die Tätigkeit im europäischen Ausland und erhöht die berufliche Mobilität.
8	D	Pflichteinsatz Pädiatrie: 120h in Kinder- und Jugendmedizin. Ebenso Pflicht: 120h Psychiatrie und 500h Vertiefungseinsatz.
9	A	SMART: Spezifisch, Messbar, Attraktiv/Akzeptiert, Realistisch, Terminiert. Schlechtes Ziel: 'Patient soll sich besser fühlen' - nicht messbar!
10	A	Der Träger der praktischen Ausbildung erstellt für jede/n Auszubildende/n einen Ausbildungsplan, der die Reihenfolge der Einsätze, die zu erreichenden Kompetenzen und die Lernziele festlegt und den roten Faden der praktischen Ausbildung bildet.
11	B	Zugang bietet in der Regel ein mittlerer Schulabschluss oder ein Hauptschulabschluss zusammen mit einer mindestens zweijährigen Berufsausbildung bzw. einer landesrechtlich geregelten Pflege(fach)assistenzausbildung.
12	A	Vorbehaltene Tätigkeiten (§ 4 PflBG) dürfen nur von ausgebildeten Pflegefachpersonen ausgeübt werden – dazu zählen die Erhebung des Pflegebedarfs, die Organisation und Steuerung des Pflegeprozesses sowie die Analyse und Evaluation der Pflegequalität.
13	D	Der Orientierungseinsatz steht am Anfang der Ausbildung und findet beim Träger der praktischen Ausbildung statt. Er dient dem Ankommen, dem Kennenlernen der Einrichtung und der grundlegenden Orientierung im Pflegealltag.
14	D	11 Curriculare Einheiten (CE): strukturieren den Theorieunterricht der GPA. Entwickelt von der Fachkommission nach §53 PflBG. CE 01 = Ausbildungsstart bis CE 11 = Koordination/Steuerung.
15	C	Salutogenese (CE 04): Gegensatz zur Pathogenese. Kohärenzgefühl = Verstehbarkeit + Handhabbarkeit + Bedeutsamkeit. Wichtig für Gesundheitsförderung.
16	C	Nahziele sind kurzfristig und in kleineren Schritten erreichbar, Fernziele (Richtziele) beschreiben das angestrebte längerfristige Gesamtergebnis. Nahziele bauen aufeinander auf und führen zum Fernziel hin.
17	D	Ressourcen sind die vorhandenen Fähigkeiten, Kräfte und Möglichkeiten eines Menschen (z. B. „kann sich mit Hilfsmittel selbst waschen“). Die Pflegeplanung stellt sie den Pflegeproblemen gegenüber und nutzt sie gezielt zur Förderung der Selbstständigkeit.
18	C	Auszubildende erhalten über die gesamte Ausbildung eine angemessene Ausbildungsvergütung. Schulgeld darf nicht erhoben werden – das macht die Ausbildung attraktiv und finanziell tragfähig.

19 **B** Kinaesthetics: Pflegende lernen natürliche Bewegungsmuster nutzen → weniger Kraftaufwand → Eigenaktivität des Patienten fördern. Weniger Rückenschäden beim Personal.

20 **C** Der Träger der praktischen Ausbildung (z. B. Krankenhaus, Pflegeeinrichtung, ambulanter Dienst) schließt den Ausbildungsvertrag, zahlt die Vergütung und verantwortet die praktische Ausbildung – organisiert über Kooperationsverträge mit der Pflegeschule und weiteren Einsatzstellen.

Pflegeprozess & Pflegeplanung

21 **D** Pflegeüberleitung (Entlassungsmanagement): Pflegeprobleme, Ressourcen, Maßnahmen, Hilfsmittelbedarf, Medikamente, soziale Situation weitergeben. Expertenstandard DNQP.

22 **C** Expertenstandard Schmerz (DNQP): 1.NRS-Einschätzung 2.Ziel mit Patient vereinbaren 3.WHO-Stufenschema + Lagerung/Wärme/Ablenkung 4.Evaluation nach 30-60 Min. 5.Patientenedukation.

23 **B** Dekubitus-Kategorien: I = nicht-wegdrückbare Rötung (Haut intakt), II = Blasen/Erosion (Teilverlust Dermis), III = Vollhautverlust bis Subkutis, IV = Muskeln/Knochen/Sehnen betroffen.

24 **A** Pflegeplanung: 1.Pflegeproblem (aktuell/potenziell), 2.Pflegeziel (SMART), 3.Pflegemaßnahmen (wer, was, wann), 4.Evaluation.

25 **B** In der Evaluation wird überprüft, ob die gesetzten Pflegeziele erreicht wurden und ob die Maßnahmen wirksam waren. Je nach Ergebnis wird die Pflegeplanung angepasst, fortgeführt oder beendet – der Pflegeprozess ist ein fortlaufender Regelkreis.

26 **A** Braden-Skala: 6 Faktoren bewertet. Max. 23 Punkte. ≤18 Punkte = Dekubitusrisiko. Je niedrigerer Wert desto höheres Risiko. Einzusetzen bei Aufnahme und bei Veränderungen.

27 **C** PSA anlegen: 1. Kittel (Körper schützen) 2. Maske/Atemschutz 3. Schutzbrille 4. Handschuhe (zuletzt – direkter Kontakt). Ablegen umgekehrt: 1. Handschuhe (kontaminiert!) 2. Kittel 3. Brille 4. Maske → dann Händedesinfektion.

28 **C** Orem: Pflege nur aktiv bei Selbstpflegedefizit. 3 Systeme: voll-kompensierend, teil-kompensierend, unterstützend-edukativ. Ziel: Selbstpflegekompetenz stärken.

29 **B** MRSA-Isolierung: Einzelzimmer (eigenes Bad), Schutzkittel, Handschuhe, FFP2-Maske bei engem Kontakt. Beim Verlassen: PSA im Zimmer ablegen → Händedesinfektion. Besuch möglich (Kittel + Handschuhe). Patienten aufklären und einbeziehen! Screening: Nasen-Rachen-Abstrich.

30 **D** Wäschesortierung: Roter Sack = Infektionswäsche (MRSA, C. diff., Norovirus, stark blutig/kontaminiert) → direkt verschließen, nicht im Zimmer sortieren, Handschuhe + Kittel. Weißer Sack = normale Wäsche. Wäsche NIE ausschütteln → Aerosolbildung → Keimverbreitung!

31 **A** Der Pflegeprozess wird häufig als sechsstufiges Regelkreismodell dargestellt: Informationssammlung, Erkennen von Problemen und Ressourcen, Festlegen der Pflegeziele, Planung der Maßnahmen, Durchführung und Evaluation. Die Schritte bauen aufeinander auf und werden fortlaufend angepasst.

32 **C** NRS: Patient bewertet Schmerz 0-10. Ab NRS ≥4 = Handlungsbedarf. Vor und nach Schmerzmedikation dokumentieren. Alternativen: VAS, BPS/CPOT (nicht-kommunikativ).

33 **C** Bei der Visuellen Analogskala (VAS) markiert der Patient seine Schmerzstärke auf einer Linie zwischen „kein Schmerz“ und „stärkster vorstellbarer Schmerz“. Sie dient – wie die numerische Rating-Skala (NRS) – der standardisierten Selbsteinschätzung und Verlaufskontrolle von Schmerzen.

34 **C** Potenzielle Pflegeprobleme = Risiken: z.B. 'Gefahr eines Dekubitus wegen Immobilität'. Erfordern prophylaktische Maßnahmen.

35 **B** Dauerhaftes Tragen ohne Indikation: falsches Sicherheitsgefühl (Desinfektion wird vergessen), Handschuhe werden zum Übertragungsweg, Hautschäden. Handschuhe ersetzen die Händedesinfektion NICHT – auch nach Handschuhwechsel desinfizieren!

36 **B** SMART: Spezifisch (konkrete Handlung: gehen), Messbar (10m), Attraktiv, Realistisch, Terminiert (3. postop. Tag). Vage Ziele sind nicht auswertbar!

37 **C** §23 IfSG: Krankenhäuser müssen nosokomiale Infektionen und Erreger mit speziellen Resistenzen (MRSA, VRE, ESBL) erfassen und bewerten. Pflicht: Hygienekommission, Krankenhaushygieniker oder -fachkraft, Surveillance-System (z.B. KISS). Ziel: Infektionsraten senken durch systematische Überwachung.

38 **C** C. difficile bildet Sporen, die durch Alkohol nicht abgetötet werden → mechanisches Händewaschen nötig. Ansonsten gilt: Hände waschen macht Schutzflora kaputt und schädigt die Haut. Desinfektion ist effektiver als Waschen!

39 **A** Ein Dekubitus Kategorie I zeigt eine umschriebene, nicht wegdrückbare Rötung bei noch intakter Haut (Fingertest positiv). Er ist ein Warnzeichen und erfordert sofortige konsequente Druckentlastung, um ein Fortschreiten in tiefere Kategorien zu verhindern.

40 **C** Nach Donabedian gliedert sich Qualität in Strukturqualität (Rahmenbedingungen wie Personal und Ausstattung), Prozessqualität (Abläufe und Durchführung der Pflege) und Ergebnisqualität (erreichter Zustand des Patienten). Alle drei zusammen bilden die Pflegequalität ab.

Prävention & Gesundheitsförderung

41 **D** Das Infektionsschutzgesetz (IfSG) regelt Melde- und Benachrichtigungspflichten, Tätigkeitsverbote und Maßnahmen zum Schutz vor übertragbaren Krankheiten.

42 **C** Empowerment befähigt Menschen, mehr Kontrolle über Entscheidungen und Handlungen zu gewinnen, die ihre Gesundheit beeinflussen.

43 **C** Verhaltensprävention verändert individuelles Verhalten (z.B. Rauchstopp), Verhältnisprävention verändert Umwelt- und Lebensbedingungen (z.B. Rauchverbote, Arbeitsschutz).

44 **C** Bei hoher Durchimpfungsrate kann sich ein Erreger kaum ausbreiten, wodurch auch nicht geimpfte oder immungeschwächte Personen indirekt geschützt werden (Gemeinschaftsschutz).

45 **B** Tertiärprävention setzt bei einer bereits bestehenden Erkrankung an und will Folgeschäden, Komplikationen und Rückfälle verhindern – etwa durch Rehabilitation, Schulungen oder Nachsorge.

46 **C** Rückenschonendes Arbeiten: in die Knie gehen und aus den Beinen heben, den Rücken gerade halten, die Last körpernah führen, Drehbewegungen vermeiden und Hilfsmittel bzw. Kinaesthetics nutzen. Das beugt Muskel-Skelett-Erkrankungen vor.

47 **D** Beratung fördert eine informierte Entscheidung; Anleitung vermittelt eine konkrete praktische Fertigkeit Schritt für Schritt.

48 **D** Beim Fingertest wird die Rötung kurz weggedrückt: Bleibt sie bestehen (nicht wegdrückbar), liegt bereits ein Dekubitus Kategorie 1 vor. Eine wegdrückbare Rötung ist eine reversible Hyperämie.

49 **A** Die hygienische Händedesinfektion ist die einfachste und wirksamste Einzelmaßnahme zur Verhütung von Krankenhausinfektionen und zur Eindämmung multiresistenter Erreger.

50 **D** Gebrauchte Kanülen kommen ohne Zurückstecken der Schutzkappe (kein Recapping!) direkt in einen durchstichsicheren, verschließbaren Abwurfbehälter – das senkt das Risiko von Nadelstichverletzungen.

51 **A** Bei MRSA (methicillinresistenter Staphylococcus aureus) gelten Barrieremaßnahmen: Einzelzimmer bzw. Isolierung, Schutzkittel, Handschuhe, konsequente Händedesinfektion und ggf. Sanierung, um die Übertragung zu verhindern.

52 **B** Die Ständige Impfkommission (STIKO) am Robert Koch-Institut erstellt die nationalen Impfempfehlungen.

53 **A** Nach einer Nadelstichverletzung: Blutfluss anregen, Wunde mit Wasser/Antiseptikum spülen und desinfizieren, dann D-Arzt bzw. Betriebsarzt aufsuchen und den Unfall dokumentieren/melden (Hepatitis- und HIV-Risiko abklären).

54 **B** Kontrakturprophylaxe beruht auf regelmäßiger aktiver und passiver Bewegung sowie physiologischer Gelenkstellung und Lagerung. Dauerhafte Ruhigstellung führt gerade zur Kontraktur.

55 **B** Zur Basis-/physikalischen Thromboseprophylaxe gehören Frühmobilisation, Bewegungsübungen, Kompression (MTPS) und ausreichende Flüssigkeit; medikamentös ergänzt niedermolekulares Heparin. Bettruhe fördert Thrombosen.

56 **B** Motivational Interviewing stärkt die intrinsische Motivation zur Verhaltensänderung durch empathische, nicht-konfrontative Gesprächsführung.

57 **B** Standardhygiene (Basishygiene) gilt bei allen Patienten unabhängig von einer bekannten Infektion – dazu zählen Händedesinfektion, Schutzhandschuhe und -kleidung nach Bedarf, sichere Entsorgung und Flächendesinfektion.

58 **B** Aufrechte Position (ca. 90°), ruhiges Tempo, kleine Bissen, angepasste Konsistenz (z. B. angedickte Flüssigkeit bei Dysphagie) und Konzentration aufs Schlucken senken das Aspirationsrisiko.

59 **B** BGM zielt darauf, Arbeitsbedingungen gesundheitsförderlich zu gestalten, Belastungen zu reduzieren und Gesundheit sowie Motivation der Beschäftigten langfristig zu erhalten (z. B. Ergonomie, Rückenschule, Pausenkultur).

60 **D** Pneumonieprophylaxe umfasst tiefe Atemübungen, Mobilisation, Oberkörperhochlagerung, Sekretmobilisation und gute Mundpflege. Immobilität und Hustendämpfung erhöhen das Risiko.

Mobilität & Bewegung

61 **D** Fixierungen sind freiheitsentziehend und mit eigenen Risiken verbunden; sie sind nur als letztes Mittel zulässig – grundsätzlich mit Einwilligung bzw. richterlicher Genehmigung. Vorrang haben schonende Alternativen.

62 **C** Die Virchow-Trias nennt die drei Hauptfaktoren der Thromboseentstehung: Gefäßwand- bzw. Endothelschaden, Stase (z. B. durch Immobilität) und Hyperkoagulabilität.

63 **A** Wechseldrucksysteme entlasten durch zyklisch wechselnden Druck und werden bei hohem Dekubitusrisiko eingesetzt – ergänzend, nicht als Ersatz für Bewegungsförderung.

64 **A** Zur Spitzfußprophylaxe wird der Fuß in physiologischer 90-Grad-Stellung gelagert (z. B. Fußstütze) und das Sprunggelenk regelmäßig bewegt.

65 **D** Ein Lifter dient dem sicheren Transfer schwer immobiler Patienten und schützt vor Sturz und Rückenschäden. Anwendung nach Einweisung und mit passendem Gurt.

66 **A** Bei aktiven Übungen bewegt der Patient selbst (fördert Kraft und Beweglichkeit); bei passiven bewegt die Pflegekraft die Gelenke, z. B. zur Kontrakturenprophylaxe bei fehlender Eigenaktivität.

67 **D** Grad 1: intakte Haut mit lokal begrenzter, nicht wegdrückbarer Rötung (Fingertest). Offene oder nekrotische Wunden entsprechen höheren Graden.

68 **D** Bewegung in vollem Bewegungsausmaß und physiologische Gelenkstellung erhalten die Beweglichkeit. Immobilität fördert Kontrakturen.

69 **A** Der Rollator hat Räder (oft mit Bremse und Sitz) für kontinuierliches Gehen; ein Gehbock wird angehoben und versetzt und gibt sehr viel Standstabilität.

70 **C** Das Bobath-Konzept ist ein neurophysiologischer Ansatz zur Förderung von Menschen mit zentralen Bewegungsstörungen (z. B. Hemiplegie nach Schlaganfall).

71 **A** Die ATL/AEDL 'Sich bewegen' umfasst Positionswechsel, Transfer, Gehen und Bewegungsübungen und bildet die Grundlage vieler Prophylaxen.

72 **D** Mikrolagerung verlagert durch kleine Bewegungen regelmäßig die Druckpunkte, ohne den Patienten stark umzulagern – schonend und dekubitusprophylaktisch wirksam.

73 **B** Kinästhetik nutzt die Eigenbewegung des Patienten; die Pflegekraft unterstützt gezielt statt zu heben – das schont den Rücken und fördert die Aktivität des Patienten.

74 **D** Ein Bewegungsförderungsplan wird individuell erstellt (Ressourcen, Risiken, Ziele), regelmäßig evaluiert und dokumentiert – gemäß Expertenstandard Mobilität.

75 **C** Aktivierende Pflege bezieht vorhandene Fähigkeiten ein und fördert Selbstständigkeit statt vollständiger Übernahme.

76 **B** Bei der Braden-Skala gilt: je niedriger der Punktwert, desto höher das Dekubitusrisiko (18 Punkte oder weniger = gefährdet).

77 **D** Vor dem Transfer: Bremsen von Rollstuhl und Bett feststellen, Fußstützen wegklappen, rutschfeste Schuhe, klare Ansage und ggf. Hilfsmittel nutzen – so werden Stürze vermieden.

78 **B** Bei fortgeschrittener pAVK kann Kompression die ohnehin reduzierte arterielle Durchblutung weiter verschlechtern – daher Vorsicht bzw. Kontraindikation und ärztliche Abklärung.

79 **B** Frühmobilisation reduziert typische Immobilitätskomplikationen (Thrombose, Pneumonie, Dekubitus, Obstipation), fördert Kreislauf und Darmtätigkeit und beschleunigt die Genesung.

80 **A** Immobilität führt zu Muskelatrophie, Osteoporose, Kontrakturen und Obstipation sowie erhöhtem Dekubitus-, Thrombose- und Pneumonierisiko.

Notfall & Akutsituationen

81 **A** Starke Blutung: sofort direkten Druck auf die Wunde, Druckverband anlegen, Extremität hochhalten; bei lebensbedrohlicher Extremitätenblutung ggf. Tourniquet. Notruf 112, Schockprophylaxe, Eigenschutz mit Handschuhen.

82 **A** B = Breathing: Atmung beurteilen – Atemfrequenz, Atemtiefe/-muster, SpO2, Auskultation, Thoraxbewegungen; ggf. Sauerstoffgabe.

83 **B** FAST: Face (hängender Mundwinkel), Arms (Armvorhalteversuch), Speech (Sprachstörung), Time (rascher Notruf). Beim Schlaganfall zählt jede Minute ('Time is brain').

84 **C** CPR startet, sobald eine Person nicht ansprechbar ist und nicht normal atmet (Schnappatmung zählt nicht als normal). Vorher Notruf 112 absetzen und – wenn möglich – einen AED holen lassen.

85 **A** Bewusstlos mit normaler Atmung: Atemwege sichern, stabile Seitenlage, Notruf 112, kontinuierliche Überwachung der Atmung – bei Veränderung sofort reagieren.

86 **D** ABCDE wird strikt in der Reihenfolge abgearbeitet: erst lebensbedrohliche Probleme der Atemwege, dann Atmung, Kreislauf usw. – jedes Problem wird sofort behandelt, bevor man weitergeht.

87 **B** C = Circulation: Puls, Blutdruck, Rekapillarisierungszeit, Blutung stillen, Zugang und Volumen.

88 **C** E = Exposure/Environment: den Patienten situationsgerecht entkleiden und vollständig untersuchen, dabei Auskühlung vermeiden (Wärmeerhalt).

89 **D** Grün = normal/Standard, maximal 90 Minuten.

90 **C** A = Airway: zuerst die Atemwege sichern bzw. freimachen (ggf. mit HWS-Schutz).

91 **C** Der hypovolämische Schock entsteht durch Volumenmangel (Blutung, Flüssigkeitsverlust). Weitere Formen: kardiogen, septisch, anaphylaktisch, neurogen.

92 **B** Defibrillierbar sind Kammerflimmern (VF) und pulslose ventrikuläre Tachykardie (pVT). Asystolie und PEA sind nicht schockbar.

93 **A** Der AED wird eingeschaltet, die Elektroden werden aufgeklebt; man folgt den Sprachanweisungen. Während Analyse und Schockabgabe darf niemand den Patienten berühren.

94 **C** Effektive Kompressionen: harte Unterlage, Tiefe 5–6 cm, Frequenz 100–120/min, vollständige Entlastung (Recoil) nach jeder Kompression und minimale Unterbrechungen.

95 **A** 100–120/min, Drucktiefe 5–6 cm, vollständige Entlastung zwischen den Kompressionen.

96 **C** Kleinflächige Verbrennungen mit handwarmem/lauwarmem Wasser kühlen (kein Eis – Erfrierungsgefahr), keine Hausmittel, Blasen nicht öffnen, locker keimarm bedecken. Bei großflächigen Verbrennungen kein ausgedehntes Kühlen (Auskühlung).

97 **B** Beim Kind (durch Fachpersonal): 5 initiale Beatmungen, dann Verhältnis 15:2, Drucktiefe etwa ein Drittel des Brustkorbdurchmessers. Laien dürfen 30:2 anwenden.

98 **A** Über Präsentationsdiagramme wird anhand von Indikatoren (Diskriminatoren) die höchste zutreffende Stufe gewählt.

99 **D** Atmung/Kreislauf werden max. 10 Sekunden geprüft. Bei fehlender normaler Atmung oder Unsicherheit sofort mit der Wiederbelebung beginnen.

100 **D** 112 ist der europaweite Notruf für Rettungsdienst und Feuerwehr. 110 ist die Polizei, 116117 der ärztliche Bereitschaftsdienst.

Innere Medizin

101 **A** Metabolische Azidose: pH und HCO3- (sowie Base Excess) sind erniedrigt. Ursachen: Ketoazidose, Laktatazidose, Nierenversagen, schwere Durchfälle. Kompensation über vertiefte Atmung (Kussmaul).

102 **D** Das Lungenödem zeigt sich durch schwere Dyspnoe, feuchte/brodelnde Rasselgeräusche und ggf. schaumigen Auswurf. Sofortmaßnahmen: Oberkörper hoch, Beine tief, Sauerstoff, Arzt.

103 **A** Bikarbonat liegt normal bei etwa 22–26 mmol/l. Es ist der metabolische Parameter und sinkt z. B. bei metabolischer Azidose.

104 **D** Chronischer Bluthochdruck schädigt Gefäße und Organe: erhöhtes Risiko für Schlaganfall, Herzinfarkt, Herzinsuffizienz sowie Nieren- und Netzhautschäden. Daher konsequente Therapie und Kontrolle.

105 **A** Tägliche Gewichtskontrolle + Ein-/Ausfuhrbilanz. Gewichtszunahme >1kg/Tag = Warnsignal für Flüssigkeitsretention → Arzt informieren!

106 **A** pH-Werte unter etwa 7,0 oder über 7,8 sind akut lebensbedrohlich (Enzym- und Organfunktion). Der Normbereich ist mit 7,35–7,45 eng.

107 **C** Asthma verläuft typischerweise anfallsartig mit weitgehend reversibler Obstruktion (oft allergisch), während die COPD eine chronische, nur teilreversible Obstruktion ist.

108 **B** Der normale arterielle pH liegt bei 7,35–7,45. Werte unter 7,35 bedeuten Azidose, über 7,45 Alkalose. Der Bereich ist eng reguliert.

109 **C** Dysphagie = Schluckstörung. Stille Aspiration (kein Husten!) besonders gefährlich → Aspirationspneumonie. Logopädie, angepasste Kostform (IDDSI), OK-Hochlagerung beim Essen, kein Strohhalm!

110 **D** BGA-Proben werden in heparinisierten Spritzen abgenommen; Luftblasen verfälschen pO2/pCO2 und müssen entfernt werden. Rasche Analyse (ggf. gekühlt), da der Zellstoffwechsel die Werte verändert.

111 **A** Typ-1-Diabetes beruht auf einem absoluten Insulinmangel durch autoimmune Zerstörung der Betazellen; Typ-2-Diabetes auf Insulinresistenz mit relativem Mangel, oft mit Übergewicht/Lebensstil assoziiert.

112 **D** Bei respiratorischer Azidose staut sich CO2 (Hypoventilation): pCO2 steigt, der pH sinkt. Zur Kompensation steigt später das HCO3- (renale Kompensation).

113 **A** Die COPD (chronisch obstruktive Lungenerkrankung) ist durch eine chronische, nicht vollständig reversible Atemwegsobstruktion gekennzeichnet – meist raucherassoziiert, mit Husten, Auswurf und Belastungsdyspnoe.

114 **D** Der pCO2 liegt normal bei etwa 35–45 mmHg. Er ist der respiratorische Parameter und steigt z. B. bei Hypoventilation.

115 **D** BZ < 70 mg/dl + Patient wach → 20g KH oral. BZ-Kontrolle nach 15 Min. Bei Bewusstlosigkeit: Glukose 40% i.v. oder Glukagon i.m.

116 **C** Bei Hyperventilation wird zu viel CO2 abgeatmet: pCO2 sinkt, der pH steigt (respiratorische Alkalose). Typisch bei Angst/Panik mit Kribbeln und Pfötchenstellung.

117 **A** Die Lungenembolie zeigt sich oft mit plötzlicher Atemnot, atemabhängigem Brustschmerz, Tachykardie, ggf. Husten/Hämoptyse; Ursache meist eine tiefe Beinvenenthrombose. Notfall – 112.

118 **D** Bobath: betroffene Seite aktivieren statt kompensieren. Patient von betroffener Seite ansprechen, Lagerung auf beiden Seiten, alle Aktivitäten beidseitig. Fördert Neuroplastizität.

119 **B** Kalium ist entscheidend für die Erregbarkeit von Herz und Muskulatur. Eine schwere Hyperkaliämie kann bedrohliche Herzrhythmusstörungen bis zum Kammerflimmern auslösen – Werte engmaschig überwachen.

120 **A** HbA1c = glykiertes Hämoglobin: zeigt Durchschnitts-BZ der letzten 8-12 Wochen. Ziel bei Diabetes meist < 7%. Nicht von Tageszeit abhängig.

Chirurgie

121 **C** Frühmobilisation reduziert Thrombose, Pneumonie, Dekubitus und paralytischen Ileus, fördert Kreislauf und Darmtätigkeit und beschleunigt die Genesung – schmerzadaptiert und sicher durchgeführt.

122 **A** Die perioperative Antibiotikaprophylaxe wird bei entsprechender Indikation rechtzeitig vor dem Hautschnitt gegeben, damit zum Operationszeitpunkt ausreichende Wirkspiegel bestehen.

123 **C** Nachblutung: Tachykardie, Blutdruckabfall, Unruhe, blasse kaltschweißige Haut, rasch zunehmende blutige Drainagemenge oder durchgeblutete Verbände – Zeichen eines beginnenden Volumenmangelschocks. Sofort Arzt informieren.

124 **A** Eine TVT zeigt sich oft einseitig mit Schwellung, Spannungs-/Schweregefühl, Überwärmung, ggf. livider Verfärbung und Schmerz. Es besteht Lungenembolie-Gefahr – ärztlich abklären, die Wade nicht ausstreichen.

125 **B** Beim Kompartmentsyndrom steigt der Druck in einer geschlossenen Muskelloge (z. B. nach Fraktur/OP) so an, dass Durchblutung und Nerven geschädigt werden. Alarmzeichen: starker, lageunabhängiger Schmerz, Blässe, Sensibilitätsstörungen – Notfall.

126 **B** Vor einem Eingriff muss der einwilligungsfähige Patient rechtzeitig ärztlich aufgeklärt werden und einwilligen. Ohne wirksame Einwilligung ist der Eingriff (außer im Notfall) rechtswidrig.

127 **A** Komplikationen nach Appendektomie: Wundinfektion (3-5%), intraabdomineller Abszess (bei Perforation), Darmparalyse/Ileus (Blähbauch, kein Darmgeräusch), Nachblutung. Frühmobilisation reduziert Ileus.

128 **A** Übliche Nüchternheitsgrenzen: klare Flüssigkeiten bis 2 Stunden, leichte/feste Nahrung bis 6 Stunden vor der Narkose – zur Vermeidung einer Aspiration bei der Narkoseeinleitung.

129 **B** Bei Drainagen werden Fördermenge und Sekretbeschaffenheit dokumentiert, Sog und Durchgängigkeit kontrolliert, die Eintrittsstelle beobachtet und Zeichen einer Nachblutung (plötzlich viel frisches Blut) erkannt.

130 **A** Die Redon-Drainage ist eine geschlossene Wunddrainage mit Sog (Unterdruck), die Wundsekret/Blut ableitet und die Wundränder anlegt. Sog und Fördermenge werden überwacht und dokumentiert.

131 **B** PONV = postoperative Übelkeit und Erbrechen, häufig nach Narkosen (Risiko u. a. Frauen, Nichtraucher, Reisekrankheit). Prophylaxe/Therapie mit Antiemetika, Aspiration vermeiden.

132 **C** Nüchternheit reduziert das Risiko, dass bei der Narkoseeinleitung Mageninhalt erbrochen und in die Lunge aspiriert wird (Aspirationspneumonie) – eine potenziell lebensbedrohliche Komplikation.

133 **D** Stomapflege: Vitalität/Farbe (rosig-feucht) beurteilen, Peristomahaut schützen, dicht sitzende Versorgung wählen, Ausscheidung beobachten und die Betroffenen schrittweise zur selbstständigen Versorgung anleiten (Psyche beachten).

134 **C** Klassische Entzündungszeichen: Rötung, Schwellung, Überwärmung, Schmerz und Funktionseinschränkung – bei Wundinfektion oft mit eitrigem Sekret und ggf. Fieber. Arzt informieren.

135 **B** Drainagen werden nach ärztlicher Anordnung gezogen, meist wenn die Sekretförderung deutlich nachgelassen hat. Vorher Menge/Verlauf dokumentieren; das Ziehen erfolgt aseptisch.

136 **B** Die Bilanzierung (Ein-/Ausfuhr inkl. Urin, Drainagen, Erbrochenes) erkennt frühzeitig Flüssigkeitsdefizite, Nachblutungen oder Nierenprobleme und steuert die postoperative Flüssigkeitstherapie.

137 **D** Wundheilung verläuft in Phasen: Exsudations-/Reinigungsphase, Granulations-/Proliferationsphase (Gefäß- und Gewebeneubildung), Epithelisierungs- und schließlich Reifungs-/Remodeling-Phase.

138 **C** Pneumonieprophylaxe: Atemübungen (Atemtrainer/Triflow), Oberkörperhochlagerung, frühe Mobilisation, gute Schmerztherapie (damit tief geatmet werden kann) und Sekretmobilisation.

139 **B** Postoperative Standardprophylaxen: Thrombose (NMH, Kompressionsstrümpfe, Frühmobilisation), Pneumonie (Atemübungen, OK-Hochlagerung), Dekubitus (Umlagerung), Sturz (Klingel griffbereit).

140 **A** Beim Harnverhalt kann die gefüllte Blase nicht spontan entleert werden (z. B. nach Narkose/Regionalanästhesie). Zeichen: Unterbauchschmerz, tastbare Blase, Harndrang ohne Miktion. Ggf. Einmalkatheterisierung.

Pädiatrie

141 **C** Bei leichter bis mäßiger Dehydration durch Durchfall/Erbrechen ist die orale Rehydratation mit einer speziellen Glukose-Elektrolyt-Lösung (ORS) die Therapie der Wahl. Reines Wasser oder zuckerhaltige Getränke gleichen die Elektrolytverluste nicht aus.

142 **A** STIKO (Ständige Impfkommission): Impfkalender für Kinder. Pflegerelevant: Impfstatus bei Aufnahme prüfen, Eltern über Nachholimpfungen informieren, Kontraindikationen beachten (akute Erkrankung, Immundefizienz). Dokumentation im Impfpass.

143 **D** Kindesmisshandlung: körperlich (Hämatome, Knochenbrüche), emotional (Vernachlässigung, psychische Gewalt), sexuell. Schutzauftrag §8a SGB VIII: Hinweise dokumentieren, Kinderarzt einbeziehen, Kinderschutzteam, ggf. Jugendamt. Schweigepflicht kann zurücktreten!

144 **A** Keuchhusten (Pertussis) ist eine bakterielle Erkrankung mit langwierigen, anfallsartigen Hustenattacken, oft mit typischem Einziehen der Luft. Für junge Säuglinge kann er lebensbedrohlich sein (Atemstillstände); Schutz bietet die Impfung, auch der Kontaktpersonen (Kokon-Strategie).

145 **B** Neonataler Ikterus: physiologisch (Tag 2-7), durch Abbau fetaler RBC (höhere Hämoglobin-Konzentration). Pathologisch: innerhalb 24h, >2 Wochen, Reifgeborene >17mg/dl → Phototherapie (Blaulicht 420-490nm). Stillen fördern erhöht Ausscheidung.

146 **A** Rooming-in: Eltern bleiben Tag und Nacht beim Kind. Vorteile: Stärkung Eltern-Kind-Bindung, Stillen fördern, Kind fühlt sich sicher, Eltern lernen Pflege, reduziert Hospitalisierungsangst. Gesetzlich verankert (§ 2 Kinderschutz).

147 **C** Das Fremdeln (etwa ab dem 8. Lebensmonat) ist ein normaler Entwicklungsschritt: Der Säugling unterscheidet vertraute von fremden Personen und reagiert auf Fremde mit Unbehagen. Es zeigt eine gesunde Bindungsentwicklung an.

148 **A** Pseudokrupp (Laryngotracheitis): meist viral (Parainfluenza). Symptome: bellender Husten, Heiserkeit, inspiratorischer Stridor, besonders nachts. Behandlung: kühle feuchte Luft (Fenster auf), Kortison (Dexamethason/Rectodelt), Kind beruhigen, bei schwerem Anfall Klinik.

149 **D** Das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV) ist eine häufige Ursache von Bronchiolitis und obstruktiver Bronchitis bei Säuglingen, v. a. in den Wintermonaten. Symptome sind Husten, Atemnot, Giemen und Trinkschwäche; Frühgeborene sind besonders gefährdet.

150 **C** GPA-Pflichteinsatz Pädiatrie: 120h in Kinder- und Jugendmedizin. Ziel: altersspezifische Besonderheiten, Entwicklungsstufen, familienorientierte Pflege.

151 **A** Exsikkose (Dehydratation): häufig bei Kinder durch Erbrechen/Durchfall. Zeichen: trockene Schleimhäute, eingesunkene Fontanelle (Säugling), stehende Hautfalte (>2s), Oligurie, dunkler Urin, Tachykardie, Lethargie. Behandlung: orale/i.v. Rehydratation.

152 **C** Vitamin D fördert die Aufnahme und den Einbau von Kalzium in die Knochen. Die Prophylaxe im ersten Lebensjahr (meist bis zum zweiten erlebten Frühsommer) beugt der Rachitis (gestörte Knochenmineralisierung) vor.

153 **D** Scharlach wird durch A-Streptokokken (Bakterien) verursacht und zeigt sich mit Fieber, Halsschmerzen, Himbeerzunge und feinfleckigem Ausschlag. Er wird mit Antibiotika (z. B. Penicillin) behandelt, um Komplikationen und Folgeerkrankungen vorzubeugen.

154 **B** Kleinkinder sind sehr neugierig und unfallgefährdet. Zur Prävention gehören Treppen- und Herdschutzgitter, Steckdosensicherungen, das sichere Verwahren von Medikamenten, Reinigungsmitteln und Kleinteilen (Verschluckungsgefahr) sowie Aufsicht am und im Wasser.

155 **B** Motorische Meilensteine: 3 Mo. = Kopfkontrolle. 5-6 Mo. = Drehen. 7-8 Mo. = freies Sitzen. 8-10 Mo. = Krabbeln. 10-14 Mo. = Stehen, erste Schritte. Variationsbreite beachten! Alarm: kein Sitzen mit 9 Mo., kein Laufen mit 18 Mo.

156 **A** Frühgeborene haben wenig Unterhautfettgewebe, eine große Körperoberfläche und eine unreife Wärmeregulation – sie kühlen rasch aus. Deshalb sind Inkubator/Wärmebett, angepasste Umgebungstemperatur, Temperaturüberwachung und die Känguru-Methode wichtig.

157 **A** Fiebersenker für Kinder (z. B. Paracetamol, Ibuprofen) werden streng nach Körpergewicht und Alter dosiert. Acetylsalicylsäure (ASS) ist bei Kindern mit fieberhaften Virusinfekten wegen des Risikos eines Reye-Syndroms zu vermeiden.

158 **D** APGAR (nach Virginia Apgar): A=Appearance (Farbe), P=Pulse (HF), G=Grimace (Reflexe), A=Activity (Tonus), R=Respiration (Atmung). Je 0-2 Punkte. 1./5./10. Minute. 7-10=gut, 4-6=mäßig, 0-3=schlecht.

159 **A** NIDCAP (Neonatal Individualized Developmental Care): entwicklungsfördernde Pflege für Frühgeborene. Elemente: Nestlagerung (Grenzen geben), gedimmtes Licht, minimale Stimulation, Clusterpflege (Eingriffe bündeln), Känguru-Methode (Hautkontakt), Eltern als Hauptbezugspersonen.

160 **B** Beikost wird meist zwischen dem Beginn des 5. und 7. Lebensmonats eingeführt, wenn das Kind Reifezeichen zeigt (z. B. Kopfkontrolle, Interesse am Essen). Vorher deckt Milch den Bedarf; zu früher Beginn erhöht Allergie- und Aspirationsrisiken.

Gynäkologie & Geburtshilfe

161 **C** Not-Sectio bei akuter Gefahr für Mutter oder Kind: path. CTG, Nabelschnurvorfall, vorzeitige Plazentalösung, Geburtsstillstand.

162 **D** Reichen Ernährung und Bewegung nicht, wird mit Insulin behandelt; orale Antidiabetika werden in der Schwangerschaft i. d. R. nicht eingesetzt.

163 **A** Die Tokolyse hemmt Wehen und verschafft Zeit, um Lungenreife abzuschließen und ggf. in ein Perinatalzentrum zu verlegen.

164 **D** Das CTG zeichnet Wehen und kindliche Herztöne auf. Herzfrequenzabfälle können auf eine fetale Hypoxie hinweisen.

165 **C** APGAR bewertet Atmung, Puls, Grundtonus, Aussehen und Reflexe (je 0–2 Punkte) bei 1, 5 und 10 Minuten. 7–10 gilt als unauffällig.

166 **B** HELLP = Hemolysis, Elevated Liver enzymes, Low Platelets – eine schwere Verlaufsform der Präeklampsie.

167 **D** Der rechtsseitige Oberbauchschmerz entsteht durch Spannung der Leberkapsel – mit Übelkeit, Kopfschmerz und Hypertonie ein Warnzeichen.

168 **D** Frühgeburt = Geburt vor abgeschlossener 37. SSW. Je unreifer, desto höher das Risiko für Atemprobleme und Infektionen.

169 **D** Korrektes Anlegen: Kind erfasst Mamille samt großem Teil des Warzenhofs, Lippen nach außen, Kinn an der Brust – beugt wunden Mamillen vor.

170 **A** Das Kind hat vermehrt Insulin gebildet; nach Wegfall des mütterlichen Zuckerangebots droht eine neonatale Hypoglykämie.

171 **D** Eröffnungsphase (Muttermund bis 10 cm), Austreibungsphase (vollständige Eröffnung bis Geburt des Kindes, Presswehen), Nachgeburtsphase (Geburt der Plazenta).

172 **C** Geburtsbeginn: regelmäßige, zunehmende Wehen, Blasensprung (Fruchtwasserabgang) und Zeichnen (Abgang des blutig-schleimigen Schleimpfropfs).

173 **C** Ursächlich beseitigt wird HELLP nur durch die Entbindung; bis dahin RR-Senkung, Magnesium (Krampfprophylaxe), Kortison (Lungenreife).

174 **D** Stillen ist nach Sectio möglich, durch Wundschmerz und verzögerten Milcheinschuss oft erschwert – aktive Stillberatung und schmerzarme Positionen helfen.

175 **A** Kortison (Betamethason) beschleunigt die kindliche Lungenreife/Surfactant-Bildung und senkt das Risiko eines Atemnotsyndroms.

176 **C** Prolaktin bildet die Milch, Oxytocin löst den Let-down-Reflex aus. Häufiges Anlegen fördert über den Saugreiz beide Hormone.

177 **D** Nach OP und im Wochenbett ist das Thromboserisiko erhöht: LMWH, Kompression, frühe Mobilisation – plus Wochenbett-Kontrollen (Fundus, Lochien).

178 **C** Der oGTT wird in der 24.–28. SSW durchgeführt, da der GDM meist symptomarm verläuft und sonst unentdeckt bliebe.

179 **A** Die U1 erfolgt unmittelbar nach der Geburt (inkl. APGAR). Die U2 folgt am 3.–10. Lebenstag mit dem Neugeborenen-Screening.

180 **C** Wegen relativ großer Körperoberfläche und unreifer Wärmeregulation drohen Auskühlung/Hypothermie – Abtrocknen, Haut-zu-Haut, Mütze beugen vor.

Psychiatrie

181 **D** OCD (ICD-10 F42): Zwangsgedanken = unwillkürliche, ichfremde, belastende Gedanken. Zwangshandlungen = ritualhafte Handlungen zur Angstreduktion (z.B. Händewaschen, Kontrollieren). Behandlung: KVT + ERP (Exposition mit Reaktionsverhinderung) + SSRI.

182 **D** De-Eskalation: 1. Sicherheit (Abstand, Fluchtwege), 2. Ruhige Haltung/Stimme, 3. Empathie zeigen, 4. Bedürfnisse erfragen, 5. Wahlmöglichkeiten anbieten, 6. Unterstützung holen. Fixierung immer letztes Mittel!

183 **B** Das bio-psycho-soziale Modell erklärt psychische Störungen als Ergebnis eines Zusammenspiels aus biologischen (Genetik, Neurotransmitter), psychischen (Denkmuster, Bewältigung) und sozialen Faktoren (Umfeld, Belastung). Es ist Grundlage einer ganzheitlichen, multiprofessionellen Behandlung.

184 **A** Das Delirium tremens ist eine lebensbedrohliche Komplikation des Alkoholentzugs mit Bewusstseins- und Orientierungsstörung, Tremor, Halluzinationen, Unruhe sowie vegetativen Zeichen (Schwitzen, Tachykardie, Blutdruckanstieg). Es erfordert engmaschige Überwachung und Behandlung.

185 **B** Einwilligungsfähigkeit meint, dass die Person Wesen, Bedeutung und Folgen einer Behandlung erfassen und danach frei entscheiden kann. Sie wird situationsbezogen beurteilt und ist unabhängig von der Geschäftsfähigkeit. Fehlt sie, greifen Betreuungsrecht bzw. Unterbringungsregeln.

186 **D** Major Depression (ICD-10 F32): Kernsymptome: depressive Stimmung, Interessenverlust, Antriebsminderung. Zusatzsymptome: Schlafstörung, Konzentrationsstörung, Schuldgefühle, Suizidgedanken, Appetitminderung. Mind. 2 Wochen.

187 **B** Merkmale einer Abhängigkeit sind u. a. starkes Verlangen (Craving), Kontrollverlust über den Konsum, Toleranzentwicklung, Entzugssymptome, Vernachlässigung anderer Interessen und fortgesetzter Konsum trotz schädlicher Folgen.

188 **B** Das maligne neuroleptische Syndrom ist eine seltene, lebensbedrohliche Komplikation einer Antipsychotika-Therapie mit hohem Fieber, ausgeprägter Muskelrigidität, Bewusstseinsstörung und vegetativer Entgleisung. Es ist ein Notfall – das Medikament wird abgesetzt und intensiv behandelt.

189 **A** Milieutherapie: gesamte Stationsumgebung als therapeutisches Instrument. Elemente: klare Tagesstruktur, soziale Regeln, Gruppenangebote (Ergotherapie, Sport, Kochen), therapeutische Gemeinschaft, Patienten übernehmen Verantwortung.

190 **C** Die stimmungsaufhellende Wirkung von Antidepressiva (z. B. SSRI) setzt meist erst nach etwa 1–3 Wochen ein, während Nebenwirkungen früher auftreten können. Wichtig sind Aufklärung, Adhärenzförderung und kein abruptes Absetzen (Absetzsymptome).

191 **C** Borderline (ICD-10 F60.3): instabile Emotionen, Impulsivität, instabile Beziehungen (Idealisierung/Entwertung), Identitätsstörung, Selbstverletzung, Suizidalität, chronische Leere. DBT (Dialektisch-Behaviorale Therapie) als Behandlung.

192 **B** Demenz (ICD-10 F00-F03): organischer, fortschreitender kognitiver Abbau. Depression: affektive Störung, behandelbar. Pseudodemenz: Depression die wie Demenz aussieht → Therapieversuch! Unterscheidung wichtig für Behandlungsplanung.

193 **B** Krisenintervention ist zeitlich begrenzte, unmittelbare Hilfe zur Stabilisierung. Ein bekanntes Schema ist BELLA: Beziehung aufbauen, Erfassen der Situation, Linderung der Symptome, Leute einbeziehen, Ansatz zur Problembewältigung. Ziel ist Entlastung und Wiederherstellung der Handlungsfähigkeit.

194 **B** Der psychopathologische Befund (z. B. nach AMDP) beschreibt systematisch Bewusstsein, Orientierung, Aufmerksamkeit, Gedächtnis, formales und inhaltliches Denken, Wahrnehmung, Affekt, Antrieb und Ich-Erleben. Pflegende beobachten diese Merkmale kontinuierlich und geben Veränderungen ans Team weiter.

195 **A** Bei Intoxikation steht die vitale Sicherung im Vordergrund: engmaschige Kontrolle von Bewusstsein, Atmung, Kreislauf; Aspirationsschutz (stabile Seitenlage bei Bewusstseinstrübung), Schutz vor Auskühlung und Selbstgefährdung. Psychische Begleitung folgt, wenn der Zustand stabil ist.

196 **D** Psychoedukation: strukturierte Vermittlung von Wissen über die Erkrankung (Was ist Schizophrenie?), Medikamente (Wirkung/NW), Frühwarnsymptome, Rückfallprävention. Fördert Compliance und Selbstmanagement.

197 **B** Therapeutische Kommunikation: aktives Zuhören, Empathie zeigen, offene Fragen stellen, spiegeln, nicht bewerten, Gefühle ansprechen, Schweigen aushalten. Basis jeder psychiatrischen Pflege.

198 **A** Psychose: Realitätsverlust, Halluzinationen, Wahn (z.B. Schizophrenie). Neurose (veraltet): Angststörungen, Zwangsstörungen, Depressionen – Realitätsbezug erhalten. Moderne Psychiatrie nutzt ICD-10/DSM-5.

199 **B** Ein strukturierter Tagesablauf (feste Zeiten für Mahlzeiten, Aktivitäten, Ruhe) gibt Orientierung und Sicherheit, wirkt Antriebslosigkeit und Grübeln entgegen und fördert Selbstständigkeit. Er ist zentraler Bestandteil der Milieutherapie, besonders bei Depression und Psychosen.

200 **B** Das Psychisch-Kranken-Gesetz (PsychKG) der Länder – in NRW das PsychKG NRW – regelt Hilfen, Schutzmaßnahmen sowie die Voraussetzungen und das gerichtliche Verfahren einer Unterbringung bei erheblicher Eigen- oder Fremdgefährdung. Patientenrechte und Kontrolle durch das Gericht stehen im Vordergrund.

Psychologie & Kommunikation

201 **A** Kongruenz bedeutet Echtheit: Das gezeigte Verhalten stimmt mit dem inneren Erleben überein. Der Gegenüber erlebt die Pflegekraft als authentisch und glaubwürdig.

202 **C** Carl Rogers nennt drei Grundhaltungen: Empathie (einfühlendes Verstehen), Kongruenz (Echtheit) und bedingungslose Wertschätzung (Akzeptanz) – sie schaffen ein hilfreiches Gesprächsklima.

203 **D** Hilfreich sind kurze, einfache Sätze, Blickkontakt, ruhige Zuwendung und das Aufgreifen von Gefühlen. Ständiges Korrigieren/Abfragen kann verunsichern; im fortgeschrittenen Stadium steht die Beziehung vor der Realitätsorientierung.

204 **C** Biografiearbeit nutzt die Lebensgeschichte, um Gewohnheiten, Vorlieben und Bedürfnisse zu verstehen und die Pflege individuell und sinnstiftend zu gestalten – besonders wertvoll bei Menschen mit Demenz.

205 **B** Deeskalation: ruhige Stimme und Körpersprache, aktiv zuhören, Bedürfnisse ernst nehmen, ausreichend Sicherheitsabstand, keine Provokation. Ziel ist, Spannung abzubauen; freiheitsentziehende Maßnahmen sind letztes Mittel.

206 **A** Ein Vorurteil ist eine vorgefasste, oft verallgemeinernde Bewertung ohne ausreichende Prüfung. In der Pflege ist es wichtig, eigene Vorurteile zu erkennen, um Menschen individuell und vorurteilsfrei zu begegnen.

207 **B** Nach Watzlawick hat jedes Verhalten Mitteilungscharakter: Auch Schweigen, Mimik oder Abwenden senden Botschaften. Man kann sich also nicht 'nicht' verhalten und damit nicht 'nicht' kommunizieren.

208 **A** GFK: 1. Beobachtung (ohne Bewertung), 2. Gefühl, 3. Bedürfnis, 4. Bitte (keine Forderung). Unterschied: Beobachtung ≠ Bewertung. Reduziert Konflikte im Team und mit Patienten.

209 **C** Der Primäreffekt beschreibt, dass frühe Eindrücke die weitere Wahrnehmung überproportional prägen. Das kann zu Fehleinschätzungen führen – daher bewusst offen bleiben und Urteile überprüfen.

210 **C** Schulz von Thun: Sachinhalt (Info), Selbstoffenbarung (über Sender), Beziehungsebene (zum Empfänger), Appell (was soll Empfänger tun?). Missverständnisse: Sender und Empfänger sprechen/hören auf verschiedenen Ebenen.

211 **A** Problemorientiertes Coping zielt darauf, die belastende Situation zu verändern (z. B. Lösung suchen). Emotionsorientiertes Coping reguliert die Gefühle (z. B. Entspannung, Umbewertung). Beide können je nach Situation sinnvoll sein.

212 **B** Empathie ist das Einfühlen in Gefühle und Sichtweise des anderen, ohne sich darin zu verlieren. Sie ist Grundlage einer vertrauensvollen Pflegebeziehung – abzugrenzen von handlungslähmendem Mitleid.

213 **A** Offene Fragen (W-Fragen: Wie, Was, Wobei) laden zum Erzählen ein und fördern das Gespräch. Geschlossene Fragen sind nur mit Ja/Nein zu beantworten und dienen der Klärung von Details.

214 **C** Selektive Wahrnehmung bedeutet, dass wir bevorzugt das wahrnehmen, was zu Erwartungen, Interessen oder Vorannahmen passt. Das kann zu einseitigen Einschätzungen führen – wichtig ist bewusste, offene Beobachtung.

215 **B** Zur nonverbalen Kommunikation zählen Mimik, Gestik, Körperhaltung, Blickkontakt, Berührung und der Tonfall (paraverbal). Sie transportiert vor allem Beziehungs- und Gefühlsbotschaften.

216 **B** Professionelle Abgrenzung heißt, mitfühlend zu sein, aber die Belastungen der Patienten nicht dauerhaft zu übernehmen. Sie ist ein wichtiger Schutz vor emotionaler Erschöpfung und Burnout.

217 **B** Konstruktiver Umgang: den Konflikt frühzeitig und sachlich ansprechen, die Perspektive des anderen anhören (aktives Zuhören), auf der Sachebene bleiben und gemeinsam nach Lösungen suchen – bei Bedarf mit Moderation.

218 **D** Ich-Botschaften beschreiben die eigene Wahrnehmung und das eigene Gefühl, ohne den anderen anzuklagen. Sie wirken weniger angreifend als Du-Botschaften (Vorwürfe) und fördern konstruktive Gespräche.

219 **D** Bedingungslose Wertschätzung meint, den Menschen als Person zu achten, unabhängig von seinem Verhalten oder seiner Meinung. Das heißt nicht, jedes Verhalten gutzuheißen – Person und Verhalten werden getrennt.

220 **A** Adhärenz beschreibt, wie sehr das Verhalten (z. B. Medikamenteneinnahme) mit den gemeinsam vereinbarten Empfehlungen übereinstimmt. Gute Adhärenz entsteht durch Information, Beteiligung und eine vertrauensvolle Beziehung.

Altenpflege & Geriatrie

221 **A** Bei einer Altersdepression klagen Betroffene häufig selbst über Gedächtnis- und Antriebsprobleme und wirken traurig oder verzweifelt, während Menschen mit beginnender Demenz Defizite oft bagatellisieren. Die Abgrenzung ist wichtig, da eine Depression gut behandelbar ist (Pseudodemenz).

222 **D** Herausforderndes Verhalten (z. B. Unruhe, Aggression) ist oft Ausdruck unerfüllter Bedürfnisse, Angst oder Schmerz. Hilfreich sind Ruhe, Wertschätzung, das Suchen nach Auslösern, validierende Kommunikation und das Anpassen der Umgebung – statt Konfrontation oder Zwang.

223 **D** Bei Osteoporose (Knochenschwund) führen schon leichte Stürze häufig zu Frakturen – besonders folgenreich ist die hüftnahe Schenkelhalsfraktur. Sie bedeutet oft Operation, längere Immobilität und Verlust von Selbstständigkeit; Sturz- und Osteoporoseprophylaxe sind daher zentral.

224 **B** Validation: demenzkranker Mensch sagt 'Ich muss nach Hause zu meinen Kindern' → NICHT: 'Ihre Kinder sind erwachsen' → SONDERN: 'Sie vermissen Ihre Kinder sehr.' Gefühle ernst nehmen, nicht in Realität zwingen.

225 **A** Kurzzeitpflege (vorübergehende vollstationäre Pflege, z. B. nach einem Klinikaufenthalt) und Verhinderungspflege (Ersatzpflege bei Ausfall der Pflegeperson) entlasten pflegende Angehörige zeitweise und überbrücken Engpässe. Beide sind Leistungen der Pflegeversicherung (SGB XI).

226 **A** Betreuungsrecht (§§1814ff BGB seit 2023): wenn Volljähriger aufgrund Krankheit/Behinderung Angelegenheiten nicht selbst regeln kann → Betreuungsgericht bestellt Betreuer. Vorrang: Vorsorgevollmacht! Betreuer handelt im Wohl der betreuten Person.

227 **A** Sterbezeichen: Rasselatmung (Sekret), Cheyne-Stokes-Atmung (periodisch), Totenflecken (Livores), kühle/blaue Extremitäten, Bewusstlosigkeit, fehlende Reflexe. Pflegerische Maßnahmen: Mundpflege (wichtigste Maßnahme!), Lagerung, Schmerzkontrolle, Familie informieren und einbeziehen, ruhige Atmosphäre.

228 **C** Die Alzheimer-Demenz ist die häufigste Demenzform. Typisch sind ein schleichender Beginn und ein langsam fortschreitender Verlust von Kurzzeitgedächtnis, Orientierung, Sprache und Alltagskompetenz. Sie ist bislang nicht heilbar, aber begleit- und teils medikamentös behandelbar.

229 **C** Die Braden-Skala ist ein Assessment-Instrument zur Einschätzung des Dekubitusrisikos. Sie bewertet Faktoren wie sensorische Wahrnehmung, Feuchtigkeit, Aktivität, Mobilität, Ernährung sowie Reibung/Scherkräfte. Ein niedriger Punktwert bedeutet ein höheres Risiko.

230 **A** Chronische Wunden im Alter: Dekubitus, Ulcus cruris (venös/arteriell), Diabetisches Fußsyndrom. Wundmanagement: Wunddokumentation (Foto, Maße, Wundtiefe, Exsudat, Infektzeichen), feuchte Wundversorgung (fördert Heilung), Ursachenbehandlung, Wundexpertenberatung (ICW-zertifiziert).

231 **D** SGB XI Leistungen: Pflegegeld (für häusliche Pflege durch Angehörige), Sachleistung (ambulanter Pflegedienst), Kombinationsleistung, vollstationäre Pflege, Kurzzeitpflege (bis 8 Wochen/Jahr), Verhinderungspflege (bis 6 Wochen), Entlastungsbetrag 125€/Monat.

232 **C** Expertenstandard Sturzprophylaxe (DNQP): Risikoeinschätzung bei Aufnahme (z.B. STRATIFY). Maßnahmen: rutschfeste Schuhe, Gehhilfen, Rufanlage in Reichweite, Medikamentenreview (Sedativa!), Umgebung sturzfrei gestalten, Toilettenpläne, Bewegungsförderung. Keine FEM als ersten Schritt!

233 **C** Polypharmazie ist die dauerhafte Einnahme mehrerer (oft fünf oder mehr) Medikamente gleichzeitig. Im Alter steigt dadurch das Risiko für Wechselwirkungen, Nebenwirkungen, Stürze und Verwirrtheit. Eine regelmäßige Überprüfung der Medikation (z. B. anhand der Priscus-Liste) ist wichtig.

234 **D** Biografiearbeit: bei Demenz oft einziger Zugang zum Menschen. Lieblingsspeisen, Musikgeschmack, Berufsbiografie, Rituale kennen → personenzentrierte Pflege. Biografiebogen bei Aufnahme ausfüllen, Angehörige einbeziehen.

235 **A** NBA: bewertet 6 Module: 1.Mobilität, 2.Kognition/Kommunikation, 3.Verhaltensweisen, 4.Selbstversorgung, 5.Krankheitsbewältigung, 6.Alltagsgestaltung. Geistige/psychische Beeinträchtigungen gleichwertig wie körperliche!

236 **B** Eine akute Verwirrtheit (Delir) hat oft eine behandelbare Ursache – z. B. Harnwegsinfekt, Exsikkose, Schmerzen, Medikamente oder Umgebungswechsel. Sie ist ein Warnzeichen: Ursachen werden gesucht und behandelt, die Umgebung wird ruhig und orientierungsfördernd gestaltet.

237 **A** Im Alter wird die Haut dünner, trockener und empfindlicher (weniger Talg, geringere Elastizität). Empfehlenswert sind schonende Reinigung, nicht zu heißes Wasser, milde Waschsubstanzen und rückfettende Pflege, um Hautrisse, Juckreiz und Infektionen zu vermeiden.

238 **A** WTG NRW (Wohn- und Teilhabegesetz): regelt stationäre Pflegeeinrichtungen, Tages-/Kurzzeitpflege, Wohngemeinschaften. Heimaufsicht prüft: Personalschlüssel, Qualitätsstandards, Bewohnerrechte, Hygiene, Sicherheit. Bewohner haben Recht auf: Selbstbestimmung, Privatsphäre, Besuch.

239 **B** Im Alter lässt das Durstempfinden nach, gleichzeitig sinkt der Wassergehalt des Körpers. Dadurch trinken ältere Menschen oft zu wenig und sind exsikkosegefährdet. Trinkpläne, Erinnerungshilfen und Getränke in Reichweite beugen vor.

240 **A** Kinästhetik in der Altenpflege: besonders wichtig bei immobilen, schwer pflegebedürftigen Menschen. Pflegende führen Bewegungen nicht durch sondern begleiten sie. Weniger Rückenschäden beim Personal, mehr Würde für Bewohner, Eigenaktivität auch bei Schwerstpflegebedürftigen fördern.

Palliativpflege

241 **C** Palliative Sedierung senkt kontrolliert und in der niedrigst nötigen Dosis das Bewusstsein, um sonst unerträgliche, therapierefraktäre Symptome (z. B. Atemnot, Unruhe) zu lindern. Sie zielt nicht auf den Tod ab und ist von aktiver Sterbehilfe klar abzugrenzen.

242 **B** Die Palliativstation ist in ein Krankenhaus integriert (Krisenintervention, Symptomkontrolle), das Hospiz ist eine eigenständige Einrichtung für die letzte Lebensphase.

243 **B** Bei infauster Prognose wird das Ziel von Heilung auf Linderung und Lebensqualität umgestellt - kein Behandlungsabbruch, sondern bestmögliche palliative Versorgung.

244 **C** Opioide verursachen fast immer Obstipation. Eine Laxanzien-Prophylaxe gehört daher zur Standardbegleitung der Opioidtherapie.

245 **B** Viele Menschen wünschen sich, zu Hause zu sterben. Ambulante Palliativangebote wie die SAPV ermöglichen durch Symptomkontrolle, Beratung und Rufbereitschaft ein würdevolles Sterben in der vertrauten Umgebung.

246 **C** Verena Kast beschreibt vier Trauerphasen: Nicht-wahrhaben-Wollen, aufbrechende Emotionen, Suchen und Sich-Trennen sowie einen neuen Selbst- und Weltbezug. Trauer verläuft individuell und nicht streng linear.

247 **A** WHO: Palliative Care verbessert die Lebensqualität von Patienten und Angehörigen bei lebensbedrohlicher Erkrankung durch Linderung von Leiden (körperlich, psychosozial, spirituell).

248 **C** In der Sterbephase steht Komfort im Vordergrund: regelmäßiges Befeuchten der Mundschleimhaut lindert Durstgefühl und Mundtrockenheit.

249 **A** Mit einer Vorsorgevollmacht bevollmächtigt man eine Vertrauensperson, im Fall der eigenen Entscheidungsunfähigkeit Angelegenheiten (z. B. Gesundheit, Aufenthalt, Finanzen) zu regeln – so wird oft eine gerichtliche Betreuung vermieden.

250 **C** Spirituelle Begleitung nimmt Sinn-, Glaubens- und Wertefragen ernst, unabhängig von einer bestimmten Religion. Sie kann Gespräche, Rituale oder die Einbindung von Seelsorge umfassen und ist Teil des ganzheitlichen Palliativansatzes.

251 **B** Bei terminaler Unruhe helfen eine ruhige, reizarme Umgebung, vertraute Bezugspersonen, beruhigende Ansprache und – nach ärztlicher Anordnung – medikamentöse Symptomkontrolle. Behebbare Ursachen wie Harnverhalt oder Schmerz sollten bedacht werden.

252 C Zeichen der Finalphase sind zunehmende Schwäche und Schläfrigkeit, Rückzug, nachlassender Appetit, marmorierte und kühle Extremitäten, veränderte Atmung (z. B. Cheyne-Stokes) sowie Rasselatmung.

253 B Übelkeit und Erbrechen werden ursachenorientiert mit Antiemetika (z. B. Metoclopramid, Haloperidol, Dimenhydrinat) behandelt; ergänzend helfen kleine Portionen, frische Luft, Mundpflege und eine ruhige Umgebung.

254 C Bei sachgerechter, an die Wirkung titrierter Gabe ist eine klinisch relevante Atemdepression selten. Die Linderung von Schmerz und Atemnot hat Vorrang.

255 A Die Versorgung Verstorbener erfolgt würdevoll und ruhig: Der Leichnam wird gewaschen und hergerichtet, Zugänge werden nach Vorgabe entfernt, kulturelle und religiöse Wünsche werden beachtet und den Angehörigen wird Zeit zum Abschied gegeben.

256 A Trauer ist ein individueller Prozess. Begleitung bedeutet Zuhören, Dasein und das Zulassen von Gefühlen ohne Bewertung.

257 C Neuropathische Schmerzen sprechen oft nur begrenzt auf klassische Analgetika an. Als Ko-Analgetika werden u. a. bestimmte Antidepressiva (z. B. Amitriptylin, Duloxetin) und Antikonvulsiva (z. B. Gabapentin, Pregabalin) eingesetzt.

258 C Ein bewusster, würdevoller Abschied am Verstorbenen hilft Angehörigen, den Verlust zu begreifen, und unterstützt eine gesunde Trauerverarbeitung. Pflegende schaffen dafür einen ruhigen, ungestörten Rahmen.

259 D Unsichere Todeszeichen wie Atem- und Pulsstillstand, Blässe, Areflexie oder weite Pupillen können auch bei Bewusstlosigkeit oder Scheintod auftreten. Erst sichere Zeichen (Totenflecke, Totenstarre, Fäulnis) beweisen den Tod.

260 B Kultur- und religionssensible Begleitung erfragt und respektiert individuelle Bedürfnisse (z. B. Rituale, Speisevorschriften, Umgang mit dem Leichnam) und vermeidet pauschale Annahmen. Im Zweifel fragt man Betroffene und Angehörige.

Rehabilitation

261 A Das SGB IX zielt auf Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung.

262 B Im BAR-Phasenmodell steht Phase A für die Akutbehandlung und Phase B für die Frührehabilitation schwer betroffener Patienten; die Phasen C–F folgen mit zunehmender Selbstständigkeit bis zur beruflichen Wiedereingliederung.

263 D Bobath bezieht die betroffene (hemiplegische) Seite aktiv ein, um Wahrnehmung und Bewegung anzubahnen - z.B. Pflege von der betroffenen Seite.

264 B Ressourcenorientierung knüpft an vorhandene Fähigkeiten an und stärkt Eigenaktivität und Selbstwirksamkeit.

265 C Die ICF (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit) betrachtet Körperfunktionen, Aktivität, Teilhabe und Kontextfaktoren - biopsychosozial.

266 C Der Barthel-Index erfasst den Grad der Selbstständigkeit bei Aktivitäten des täglichen Lebens (z. B. Essen, Waschen, Ankleiden, Mobilität) und dient als Verlaufsmaß in der Rehabilitation.

267 A Basale Stimulation (Fröhlich/Bienstein) fördert Wahrnehmung, Bewegung und Kommunikation bei wahrnehmungs- und bewegungsbeeinträchtigten Menschen.

268 C Bei Aphasie (Sprachstörung) helfen ruhiges Tempo, kurze einfache Sätze, Blickkontakt, nonverbale Hilfen (Gestik, Bilder) und Geduld. Bevormunden oder Vorwegnehmen von Sätzen sollte vermieden werden.

269 B Nach einer Amputation gehören tägliche Hautinspektion, sorgfältige Reinigung und fachgerechtes Wickeln (Kompression) zur Ödemreduktion und Formung des Stumpfes zur Vorbereitung der Prothesenversorgung.

270 B Beim Ankleiden wird die betroffene Seite zuerst angezogen, weil sie unbeweglicher ist. Merksatz: „betroffen zuerst an“ – beim Ausziehen umgekehrt die gesunde Seite zuerst.

271 A Aktivierend-therapeutische Pflege integriert therapeutische Konzepte (z.B. Bobath, Kinästhetik) in den pflegerischen Alltag und fördert Reha-Ziele rund um die Uhr.

272 D Kinästhetik unterstützt Menschen dabei, sich mit möglichst wenig Kraftaufwand selbst zu bewegen. Statt zu heben, wird Bewegung angebahnt und begleitet – das schont Patient und Pflegende und fördert die Selbstständigkeit.

273 C Nach dem Grundsatz „Reha vor Pflege“ soll durch rechtzeitige Rehabilitation Pflegebedürftigkeit vermieden, überwunden oder gemindert werden – Reha hat also Vorrang vor reinen Pflegeleistungen.

274 D Interprofessionelle Rehabilitation verbindet u.a. Pflege, Medizin, Physio-, Ergotherapie, Logopädie und Sozialdienst.

275 B Geriatrische Reha will Alltagskompetenz und Selbstständigkeit erhalten bzw. wiederherstellen - Grundsatz 'Reha vor Pflege'.

276 D Für die Rehabilitation nach einem Arbeitsunfall oder einer Berufskrankheit ist die gesetzliche Unfallversicherung (Berufsgenossenschaft) zuständig und leistet „mit allen geeigneten Mitteln“.

277 D Die AHB schließt sich direkt an eine Akutbehandlung (z.B. OP, Schlaganfall) an, um den Behandlungserfolg zu sichern.

278 C Ergotherapie zielt darauf, die Handlungsfähigkeit und Selbstständigkeit im Alltag wiederherzustellen – z. B. Training von Anziehen, Essen, Feinmotorik sowie Anpassung und Nutzung von Hilfsmitteln.

279 A Der Grundsatz 'Reha vor Pflege' (SGB) bedeutet: Rehabilitationsmaßnahmen sollen Pflegebedürftigkeit vermeiden oder mindern, bevor Pflege greift.

280 A Beim Ausziehen wird die gesunde Seite zuerst befreit, sodass der weniger bewegliche betroffene Arm anschließend leichter aus dem Kleidungsstück geführt werden kann („gesund zuerst aus, betroffen zuerst an“).

Anatomie: Herz & Kreislauf

281 C Der Sympathikus bereitet auf Leistung vor: Herzfrequenz und Blutdruck steigen, Pupillen und Bronchien weiten sich, die Verdauung wird gedrosselt.

282 C In der Diastole erschlaffen die Kammern und füllen sich mit Blut aus den Vorhöfen.

283 C Das Pulsoxymeter misst nichtinvasiv die periphere O_2-Sättigung (SpO_2) und die Pulsfrequenz – z. B. am Finger oder Ohrläppchen.

284 A Bradykardie = Herzfrequenz unter 60/min. Tachykardie = über 100/min.

285 A Das Myokard ist die kräftige Herzmuskelschicht – am dicksten in der linken Kammer.

286 A Die Pulskontrolle gibt Hinweise auf Frequenz, Rhythmus, Füllung und Kreislaufzustand – wichtig zur Früherkennung von Arrhythmien, Schock oder Verschlechterung.

287 B Die Aortenklappe (Taschenklappe) öffnet sich in der Systole, damit Blut in die Aorta ausgeworfen wird.

288 B Die Pfortader (V. portae) sammelt das nährstoffreiche Blut aus dem Darm und leitet es zur Leber, bevor es in den großen Kreislauf gelangt.

289 D HZV = Schlagvolumen × Herzfrequenz. In Ruhe ca. 5 l/min (z. B. 70 ml × 70/min).

290 A Die Aorta ist die größte Arterie – sie entspringt der linken Kammer und versorgt den gesamten Körperkreislauf.

291 D Die rechte Herzhälfte pumpt sauerstoffarmes Blut über die Pulmonalarterie in den Lungenkreislauf zur Sauerstoffaufnahme.

292 A Arterien führen Blut vom Herzen weg, Venen zum Herzen hin. Ausnahme von der O_2-Regel: Die Pulmonalarterie führt sauerstoffarmes Blut.

293 D Systole = Kontraktion der Kammern mit Blutauswurf. Diastole = Erschlaffung und Füllung der Kammern.

294 A Venenklappen verhindern den Rückfluss; zusammen mit der Muskelpumpe fördern sie den venösen Rückstrom zum Herzen entgegen der Schwerkraft.

295 B Rechts liegt die Trikuspidalklappe (3 Segel). Links die Mitral-/Bikuspidalklappe (2 Segel).

296 D Normaler Ruhepuls 60–100/min. Unter 60 = Bradykardie, über 100 = Tachykardie.

297 B Segelklappen (AV-Klappen: Trikuspidal, Mitral) liegen zwischen Vorhof und Kammer; Taschenklappen (Pulmonal, Aorta) an den Kammerausgängen.

298	C	Die Koronararterien versorgen das Myokard. Ein Verschluss führt zur Mangeldurchblutung → Herzinfarkt (Myokardinfarkt).
299	D	Der QRS-Komplex zeigt die Erregungsausbreitung über beide Kammern (Ventrikel).
300	D	Die beiden oberen Höhlen sind die Vorhöfe (Atrien), die unteren die Kammern (Ventrikel).

Bestehen ist planbar. Mit der PLAN-App.

Prüfungsfragen mit Erklärungen, Krankheitsbilder, Pflegeplanung und KI-Lernhilfe – kostenlos auf **plan-nrw.de**

© PLAN Digital · Patrick Schenkelberger. Nur für den persönlichen Gebrauch. Weitergabe, Weiterverkauf und Veröffentlichung nicht gestattet.